AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 04 · RP · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

55	21	6
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 04

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 04 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 33

Índice por tipo de imagen 38

Soluciones de la autoevaluación 42

Signos con nombre propio 36

Autoevaluación 39

01 Vía Aérea Obstructiva y Función Pulmonar

1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

01 Curvas flujo-volumen 4

1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

02 Inhalador con aerocámara 4

03 Prueba broncodilatadora positiva 5

1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

04 EPOC: hiperinsuflación 5

05 Tipos de enfisema 6

06 Enfisema centrolobulillar en la TAC 6

02 Infecciones Respiratorias Bajas y Supuraciones

2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)

07 Neumonía: consolidación lobar 7

08 Broncograma aéreo 7

2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

09 Neumonía por Mycoplasma 8

10 Neumonía aspirativa 8

11 Neumonía por Klebsiella 9

2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

12 Absceso pulmonar 9

13 Quiste hidatídico pulmonar complicado 10

2.5 Tuberculosis Pulmonar

14 Aspectos radiológicos de la TBC 10

15 Baciloscopía (Ziehl-Neelsen) 11

16 TBC miliar en la radiografía 11

03 Patología Pleural y Urgencias Torácicas

3.1 Derrame Pleural

17 Derrame pleural 12

18 Ecografía pleural: derrame 12

3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

19 Derrame encapsulado 13

20 Derrame pleural masivo izquierdo 13

21 Derrame pleural en la Rx de tórax 14

3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

22 Neumotórax: inspiración y espiración 14

3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

23 Neumotórax a tensión 15

24 Tórax volante 15

3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

25 Derrame pleural masivo 16

26 Mesotelioma pleural 16

04 Oncología Pulmonar, Intersticio y Vascular

4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS)

27 Hamartoma: calcificación en palomitas de maíz 17

28 Masa pulmonar de bordes irregulares 17

29 Nódulo parcialmente sólido 18

30 Nódulo pulmonar espiculado 18

31 PET-CT: nódulo hipercaptante 19

Índice por tema · continuación

4.2 Cáncer Pulmonar

32 Adenocarcinoma de pulmón 19
33 Carcinoma epidermoide 20
34 Acropaquias (dedos en palillo de tambor) 20
35 Síndrome de vena cava superior en la TAC 21
36 Síndrome de vena cava superior 21

4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

37 Fibrosis pulmonar idiopática: panal de abejas 22
38 Fibrosis pulmonar en la radiografía 22
39 NINE: vidrio esmerilado 23
40 Silicosis crónica 23
41 Asbestosis en la TACAR 24

4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo

42 Trombosis venosa profunda 24
43 ECG en TEP: S1Q3T3 25
44 AngioTAC: defecto de llenado 26
45 Ecocardiograma: VD dilatado 26

4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

46 Bronquiectasias 27
47 Bronquiectasias graves 27

05 Cuidados Críticos, Ventilación y Medicina del Sueño

5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA)

48 Síndrome de distrés respiratorio agudo 28
49 Edema pulmonar cardiogénico 28
50 Líneas B de Kerley 29

5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

51 Polisomnografía 29
52 Apnea obstructiva en la polisomnografía 30

5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

53 Monóxido de carbono y curva de disociación 30

5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

54 Ahogamiento: edema pulmonar no cardiogénico 31
55 Hipotermia: onda J de Osborn 32

01 TEMA 1.1 · ESPIROMETRÍA Y PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR

ESQUEMA

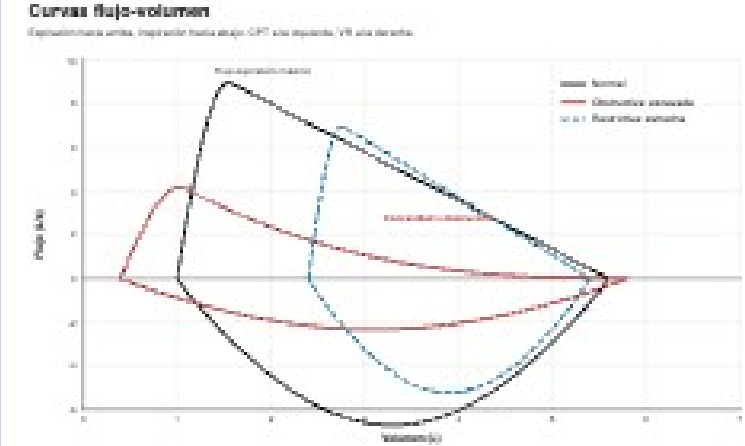


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- Obstrucción: VEF1/CVF < 0,70 post-broncodilatador
- Restricción: solo se sugiere (CVF < 80% con relación normal)

DIAGNÓSTICO

Curvas flujo-volumen

La obstructiva se hunde (concavidad); la restrictiva es estrecha.

CONDUCTA INICIAL

La restricción se confirma con pletismografía (CPT < 80%).

1.05.4.005	Espirometría
	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Curva normal: descenso lineal tras el pico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 7** Tema 1.1

Clase 1.1 en video

02 TEMA 1.3 · ASMA BRONQUIAL CRÓNICA Y MANEJO GINA/GES

ESQUEMA

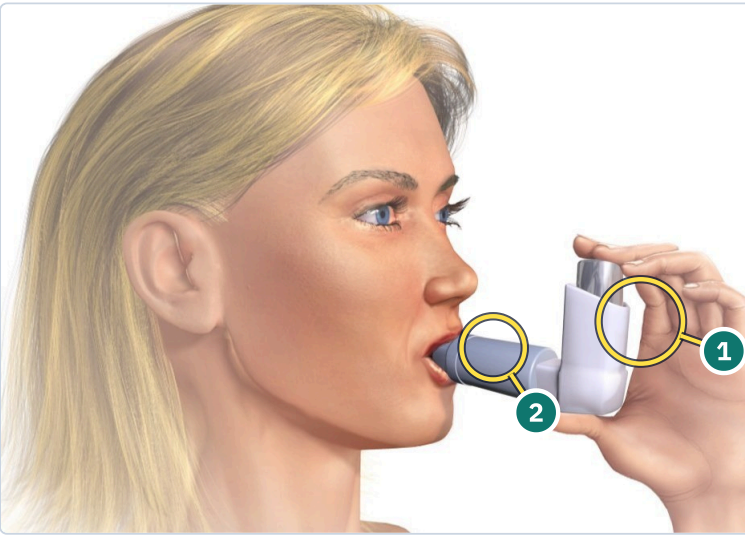


Imagen: Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1. Inhalador acoplado a la aerocámara
2. Labios sellados en la boquilla

DIAGNÓSTICO

Inhalador con aerocámara

Los labios sellan la boquilla y se dispara una sola vez.

CONDUCTA INICIAL

Antes de subir un escalón, revisar la técnica inhalatoria y la adherencia.

1.05.5.006	Inhalación de aerosoles presurizados	examen/procedimiento
1.05.1.003	Asma bronquial leve y moderada	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Disparar sin aerocámara: más depósito orofaríngeo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 14** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

03 TEMA 1.3 · ASMA BRONQUIAL CRÓNICA Y MANEJO GINA/GES

ESQUEMA

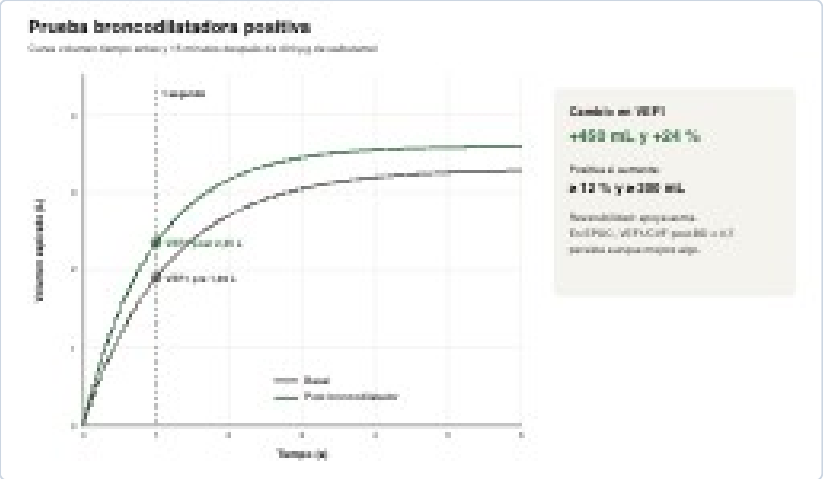


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- VEF1 antes y después del broncodilatador

DIAGNÓSTICO

Prueba broncodilatadora positiva

El VEF1 sube ≥ 12% y ≥ 200 mL tras el salbutamol.

CONDUCTA INICIAL

Reversibilidad: apoya asma; si la espirometría es normal y la sospecha persiste, test de metacolina.

1.05.4.005	Espirometría	examen/procedimiento
1.05.4.012	Prueba de provocación bronquial con fármacos	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

EPOC: VEF1/CVF < 0,70 persiste aunque mejore algo.

PREGUNTA REAL — **Julio 2024 · P163** «Una paciente de 19 años presenta disnea, asociada a tos y ocasionalmente sibilancias. Refiere que sus síntomas suelen ser más frecuentes e…» → **Prueba de provocación bronquial con metacolina**

TOMO RESPIRATORIO **p. 14** Tema 1.3

Clase 1.3 en video

04 TEMA 1.4 · ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) ESTABLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

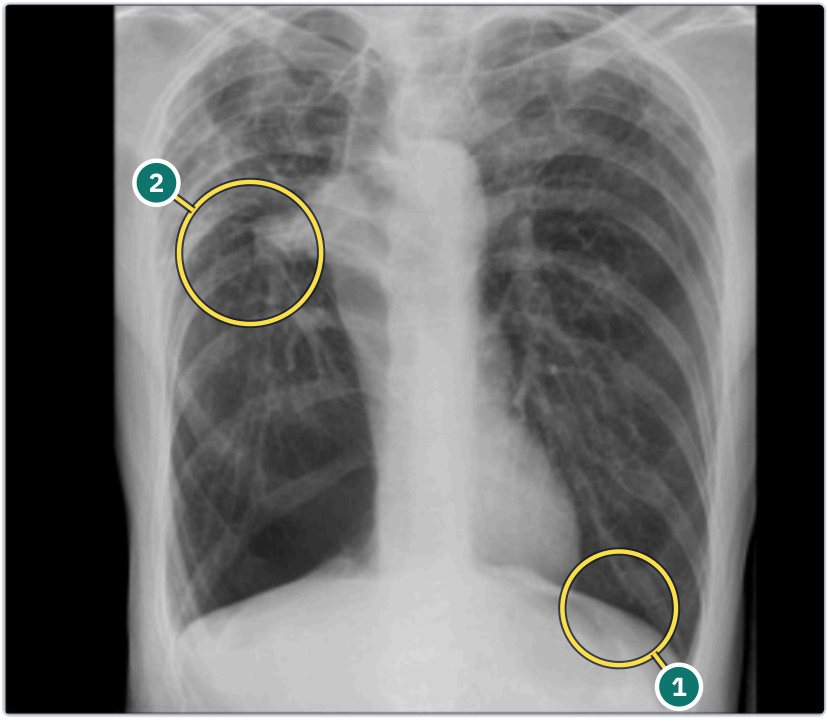


Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 22.2

QUÉ TIENES QUE VER

1. Diafragma aplanado
2. Campos pulmonares hiperclaros

DIAGNÓSTICO

EPOC: hiperinsuflación

Pulmones hiperinsuflados con diafragmas aplanados.

CONDUCTA INICIAL

Diagnóstico solo con espirometría; dejar de fumar y oxígeno ≥ 15 h/día si PaO_2 ≤ 55 prolongan la sobrevida.

1.05.1.017	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
1.05.1.016	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Asma en crisis: también hiperinsuflación transitoria.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P175** «Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50%» → **EPOC**

TOMO RESPIRATORIO **p. 17** Tema 1.4

Clase 1.4 en video

05 TEMA 1.4 · ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) ESTABLE

ESQUEMA



Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 43

QUÉ TIENES QUE VER

1. Centroacinar: destruye el centro del acino
2. Panacinar: todo el acino

DIAGNÓSTICO

Tipos de enfisema

Centroacinar (del fumador), panacinar (déficit de alfa-1 antitripsina) y paraseptal.

CONDUCTA INICIAL

Enfisema en joven no fumador: medir alfa-1 antitripsina.

1.05.1.017 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Bronquitis crónica: tos con expectoración ≥ 3 meses por 2 años.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 17 Tema 1.4

Clase 1.4 en video

06 TEMA 1.4 · ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) ESTABLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

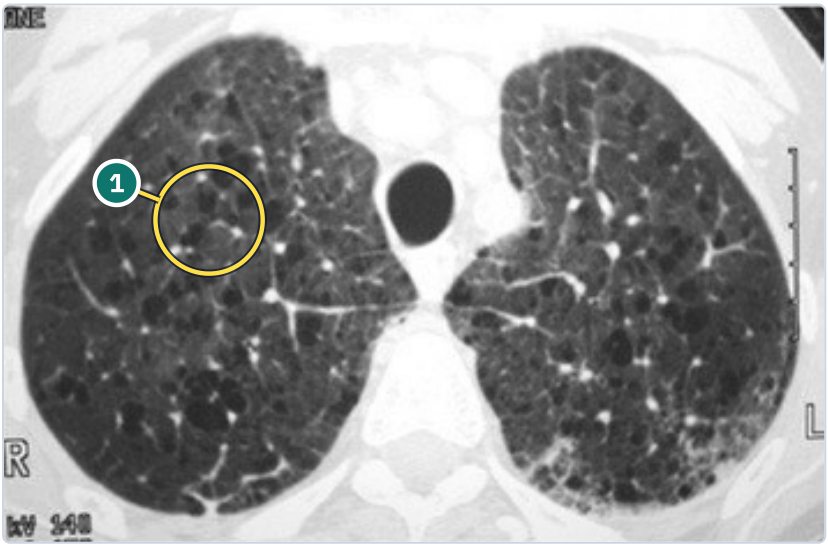


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 144

QUÉ TIENES QUE VER

1. Espacios aéreos sin pared

DIAGNÓSTICO

Enfisema centrolobulillar en la TAC

Áreas de hipoatenuación sin pared en los lóbulos superiores del fumador.

CONDUCTA INICIAL

Dejar de fumar; espirometría para el diagnóstico de EPOC.

1.05.1.017 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Bronquiectasias: tienen pared.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 17 Tema 1.4

Clase 1.4 en video

07 TEMA 2.1 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)

IMAGEN RADIOLÓGICA

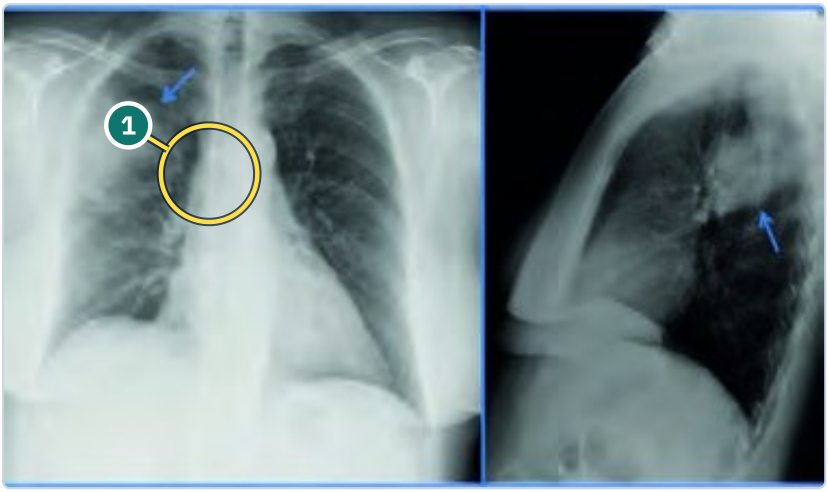


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Consolidación del lóbulo superior derecho

DIAGNÓSTICO

Neumonía: consolidación lobar

Área blanca homogénea en el lóbulo superior derecho, delimitada por la cisura.

CONDUCTA INICIAL

Sin radiografía no hay NAC; CURB-65 decide dónde tratar.

1.05.1.027	Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.05.4.001	Radiografía de tórax	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Atelectasia: pérdida de volumen con desplazamiento de cisuras.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P127** «Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos…» → **Amoxicilina**

TOMO RESPIRATORIO **p. 29** Tema 2.1

Clase 2.1 en video

08 TEMA 2.1 · NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)

IMAGEN RADIOLÓGICA

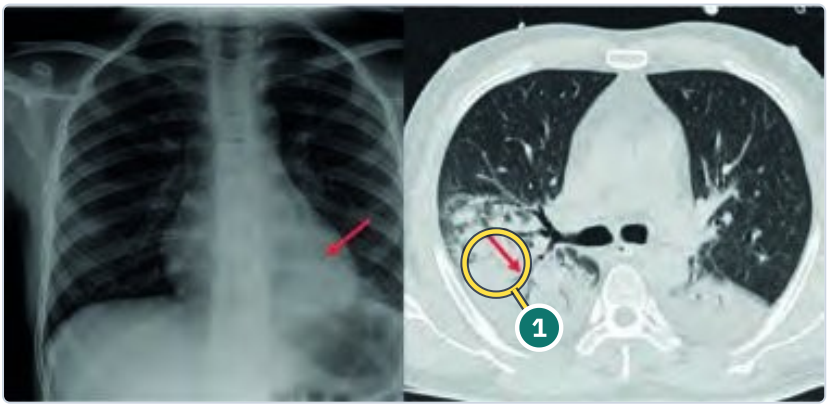


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Broncograma en la consolidación (flechas)

DIAGNÓSTICO

Broncograma aéreo

Bronquios con aire que se ven oscuros dentro de la condensación.

CONDUCTA INICIAL

Confirma ocupación alveolar: neumonía.

1.05.1.027	Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame pleural: sin broncograma.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 29** Tema 2.1

Clase 2.1 en video

09 TEMA 2.3 · NEUMONÍAS ATÍPICAS, INTRAHOSPITALARIAS Y NEUMONÍA ASPIRATIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

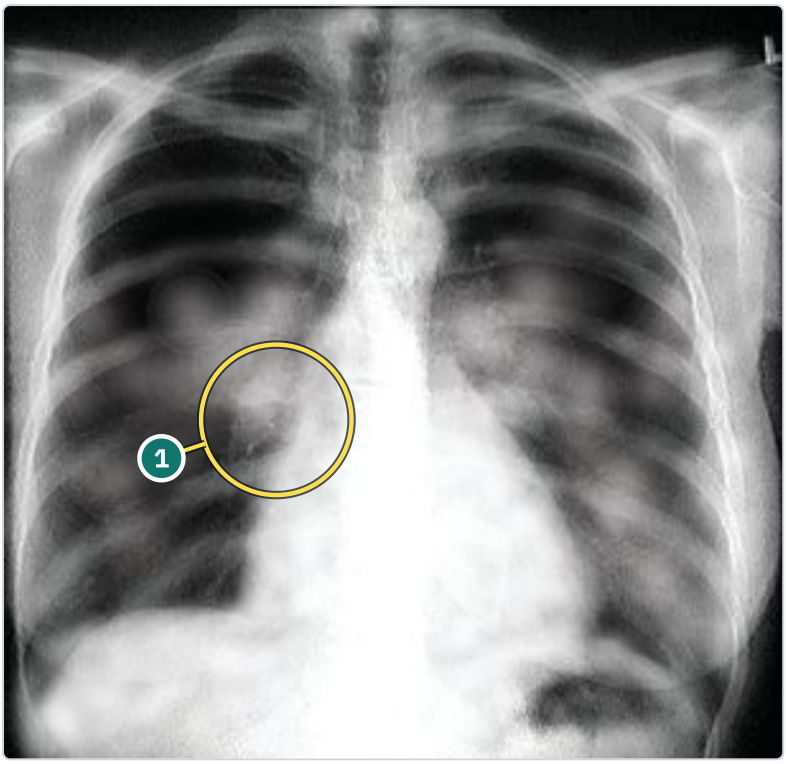


Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 56

QUÉ TIENES QUE VER

1 Infiltrado perihiliar bilateral

DIAGNÓSTICO

Neumonía por Mycoplasma

Infiltrado intersticial perihiliar bilateral: disociación clínico-radiológica.

CONDUCTA INICIAL

Macrólido (claritromicina o azitromicina): son resistentes a betalactámicos.

1.05.1.027 **Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía neumocócica: consolidación lobar.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P15** «Un paciente de 21 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, de 2 días de evolución. Al examen…» → **Claritromicina**

TOMO RESPIRATORIO **p. 36** Tema 2.3

Clase 2.3 en video

10 TEMA 2.3 · NEUMONÍAS ATÍPICAS, INTRAHOSPITALARIAS Y NEUMONÍA ASPIRATIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

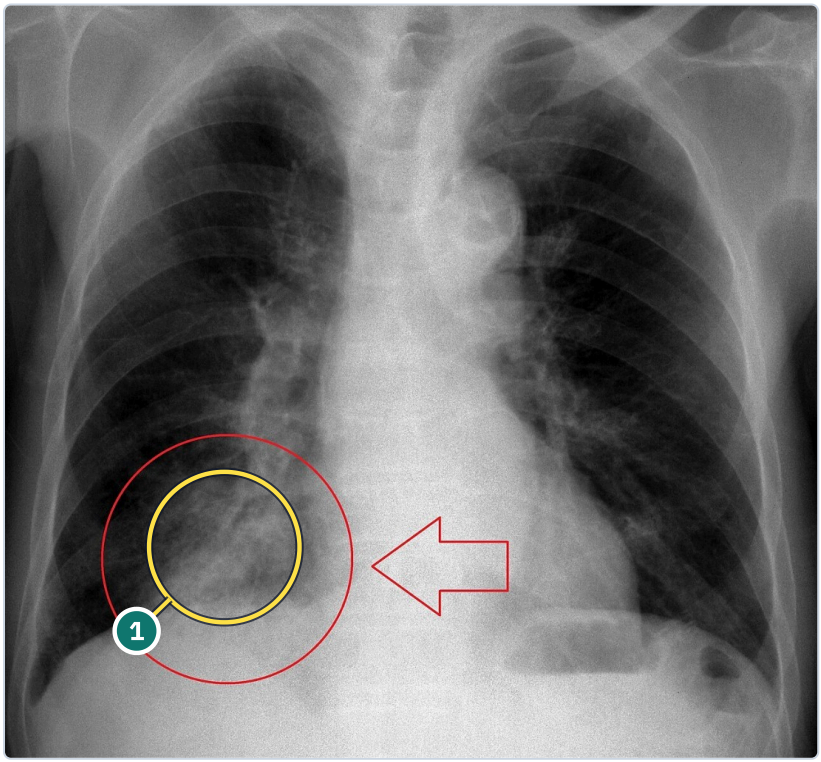


Imagen: Wikimedia Commons «Aspiration pneumonia201711-3264.jpg», CC BY-SA 4.0, melvil

QUÉ TIENES QUE VER

1 Consolidación basal derecha

DIAGNÓSTICO

Neumonía aspirativa

Consolidación en el lóbulo inferior derecho (segmentos declives).

CONDUCTA INICIAL

Ampicilina/sulbactam o amoxicilina/clavulánico (anaerobios).

1.05.1.027 **Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias)**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía neumocócica: sin trastorno de deglución.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 36** Tema 2.3

Clase 2.3 en video

11 TEMA 2.3 · NEUMONÍAS ATÍPICAS, INTRAHOSPITALARIAS Y NEUMONÍA ASPIRATIVA

IMAGEN RADIOLÓGICA

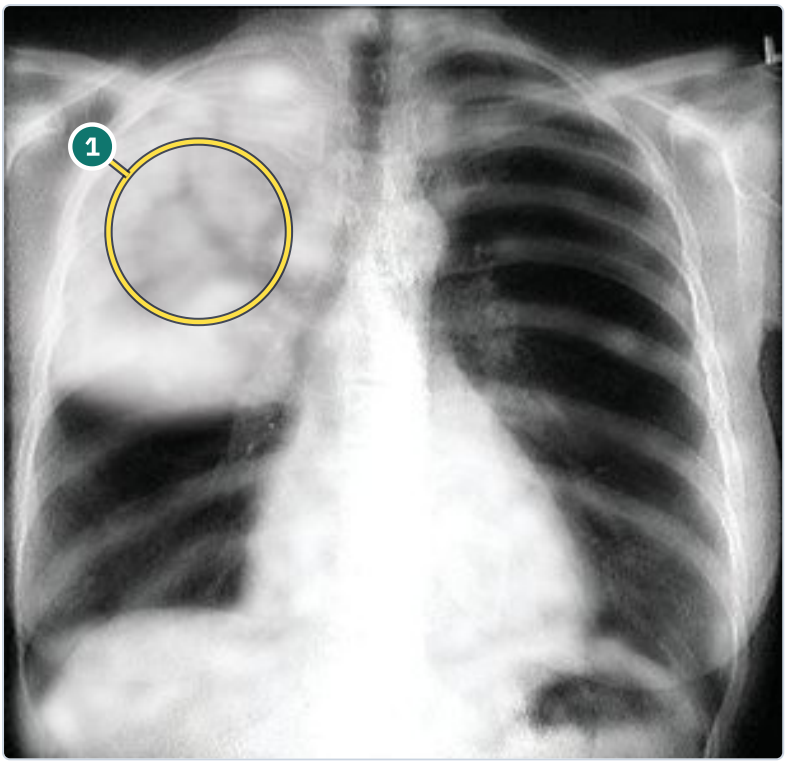


Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 56

QUÉ TIENES QUE VER

1. Consolidación del lóbulo superior derecho

DIAGNÓSTICO

Neumonía por Klebsiella

Consolidación densa del lóbulo superior derecho.

CONDUCTA INICIAL

Neumonía intrahospitalaria: cobertura de gramnegativos y antipseudomona.

1.05.1.030 **Neumonías nosocomiales**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

TBC: cavitación apical.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 36** Tema 2.3

Clase 2.3 en video

12 TEMA 2.4 · ABSCESO PULMONAR Y SUPURACIONES PLEUROPULMONARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

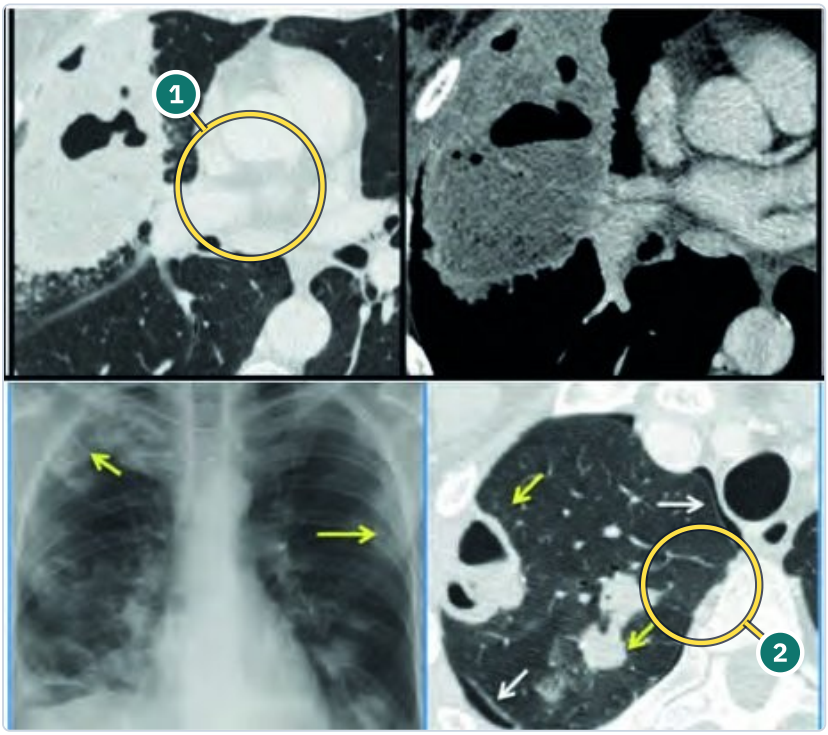


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 16

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cavidad con nivel hidroaéreo
2. Émbolos sépticos (flechas)

DIAGNÓSTICO

Absceso pulmonar

Cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.

CONDUCTA INICIAL

Antibióticos 4-6 semanas (ampicilina/sulbactam); en fumador > 50 años, descartar cáncer.

1.05.1.001 **Absceso pulmonar**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Carcinoma epidermoide cavitado: pared irregular.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P165** «Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta…» → **TAC de tórax**

TOMO RESPIRATORIO **p. 40** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

13 TEMA 2.4 · ABSCESO PULMONAR Y SUPURACIONES PLEUROPULMONARES

IMAGEN RADIOLÓGICA

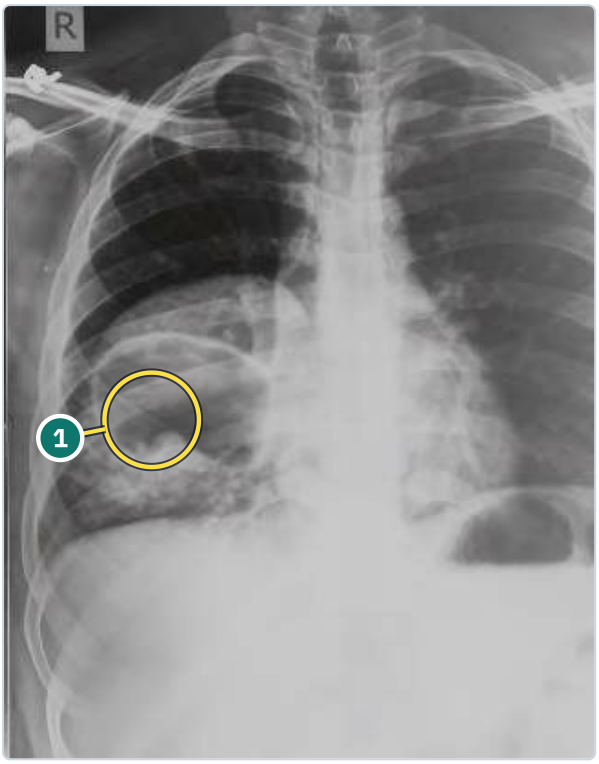


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 88

QUÉ TIENES QUE VER

1. Media luna de aire sobre el quiste

DIAGNÓSTICO

Quiste hidatídico pulmonar complicado

Signo del menisco o de la media luna: aire entre las membranas del quiste.

CONDUCTA INICIAL

Cirugía y albendazol.

1.05.1.020 Hidatidosis pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aspergiloma: masa móvil dentro de una cavidad.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 40 Tema 2.4

Clase 2.4 en video

14 TEMA 2.5 · TUBERCULOSIS PULMONAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

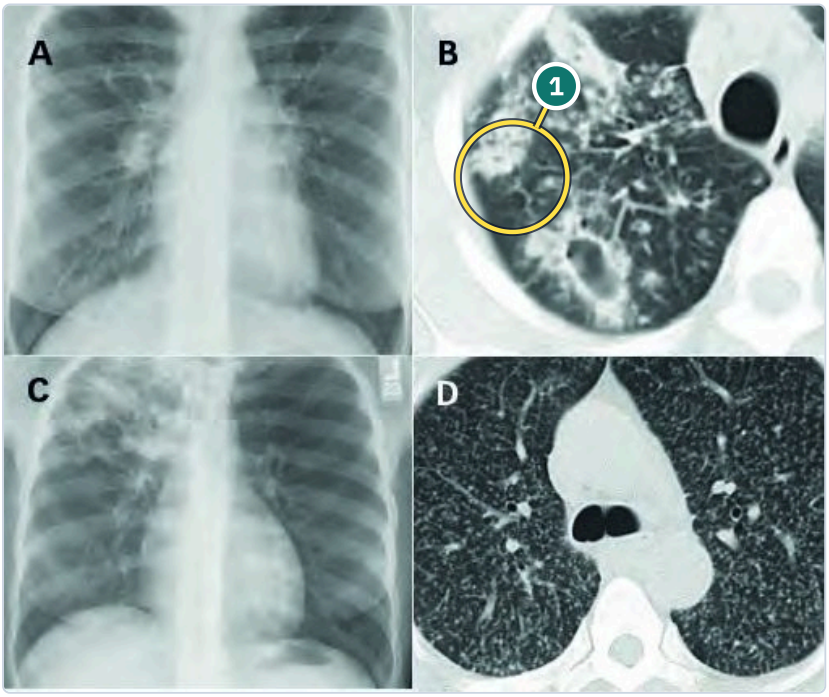


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 14

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cavitación de la TBC secundaria

DIAGNÓSTICO

Aspectos radiológicos de la TBC

A complejo de Ghon, B y C TBC secundaria cavitada, D miliar.

CONDUCTA INICIAL

Sintomático respiratorio (tos ≥ 15 días): 2 baciloscopías y GeneXpert.

1.05.1.036 Tuberculosis pulmonar — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Neumonía bacteriana: no cavita en vértices.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 43 Tema 2.5

Clase 2.5 en video

15 TEMA 2.5 · TUBERCULOSIS PULMONAR

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

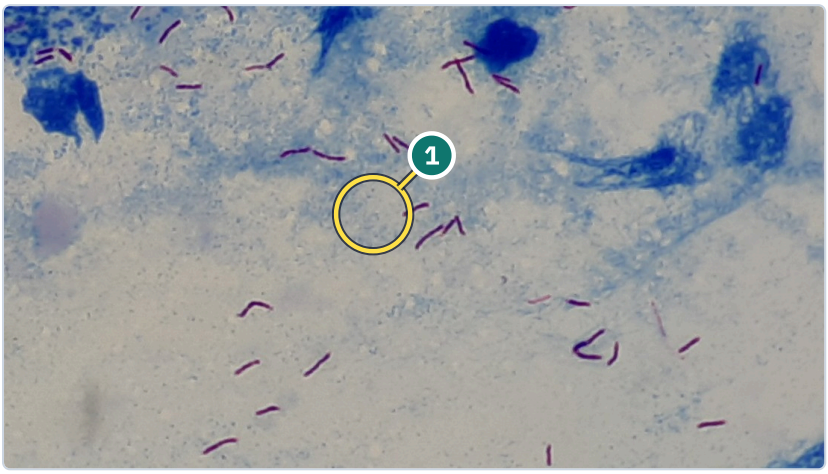


Imagen: Wikimedia Commons, CC0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bacilos (BAAR)

DIAGNÓSTICO

Baciloscopía (Ziehl-Neelsen)

Bacilos ácido-alcohol resistentes rojos o morados sobre fondo azul.

CONDUCTA INICIAL

Dos muestras: una inmediata y otra matinal; una negativa no descarta (necesita > 5.000 bacilos/mL).

1.05.4.004 **Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Gram: no tiñe bien la micobacteria.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P49 «Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos…» → **Baciloscopías seriadas**

TOMO RESPIRATORIO **p. 43** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

16 TEMA 2.5 · TUBERCULOSIS PULMONAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

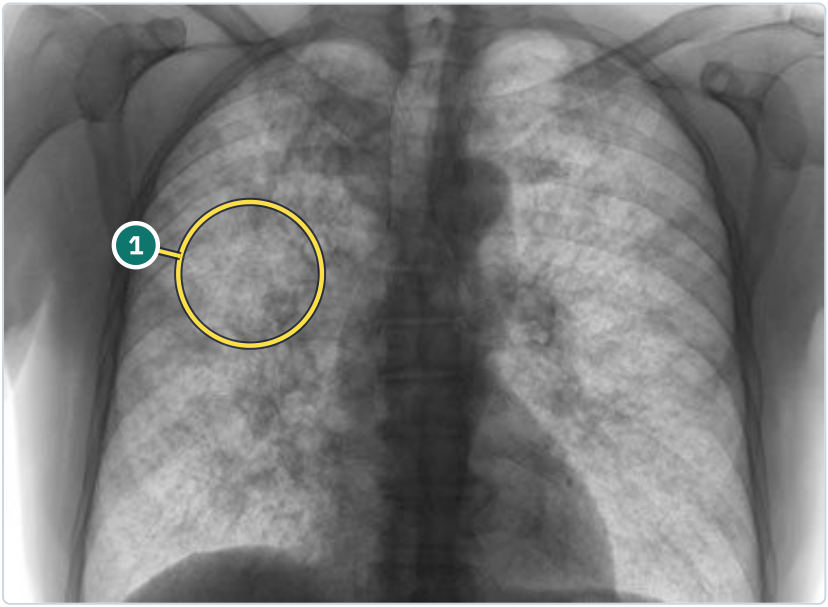


Imagen: Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 66

QUÉ TIENES QUE VER

1 Micronódulos difusos

DIAGNÓSTICO

TBC miliar en la radiografía

Patrón micronodular difuso en grano de mijo.

CONDUCTA INICIAL

Miliar: 6 a 12 meses de tratamiento.

1.05.1.036 **Tuberculosis pulmonar**

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Neumoconiosis: nódulos de predominio superior.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO RESPIRATORIO **p. 43** Tema 2.5

Clase 2.5 en video

17 TEMA 3.1 · DERRAME PLEURAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

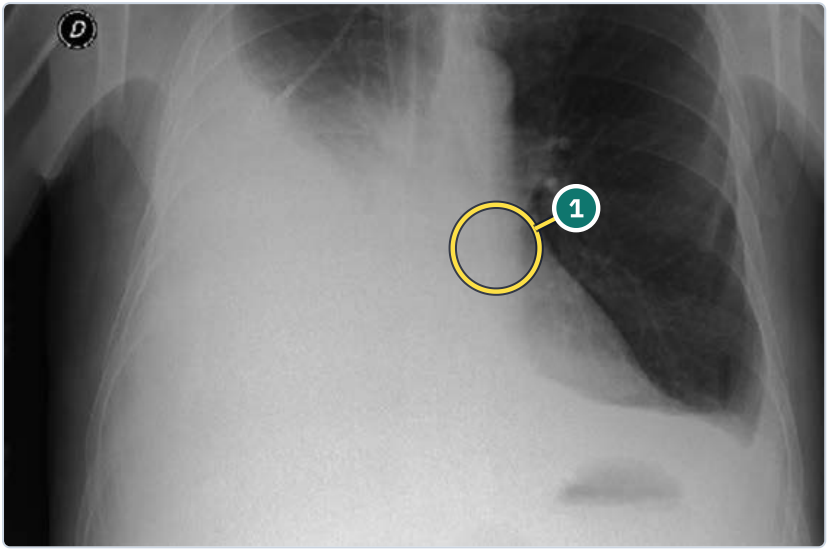


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

QUÉ TIENES QUE VER

1 Menisco pleural

DIAGNÓSTICO

Derrame pleural

Opacidad con borde en menisco que borra el ángulo costofrénico.

CONDUCTA INICIAL

Toracocentesis: un solo criterio de Light = exudado.

1.05.4.007	Citoquímico de líquido pleural	examen/procedimiento
1.05.5.009	Punción pleural	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Atelectasia: tira el mediastino hacia el mismo lado.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P94 «Paciente con derrame pleural unilateral. Se realiza toracocentesis. ¿Cuál es el examen del líquido pleural que permite clasificarlo como exudado…» → **Proteínas y LDH en líquido pleural y suero**

TOMO RESPIRATORIO **p. 52** Tema 3.1

Clase 3.1 en video

18 TEMA 3.1 · DERRAME PLEURAL

ECOGRAFÍA

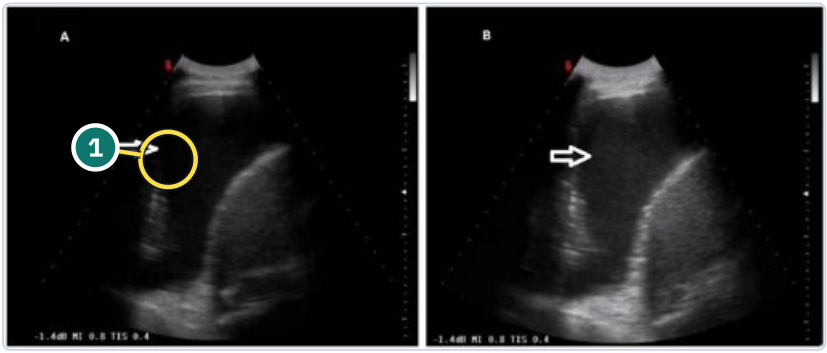


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Derrame anecoico (flecha)

DIAGNÓSTICO

Ecografía pleural: derrame

Líquido anecoico (negro) sobre el diafragma; detecta desde 20 mL.

CONDUCTA INICIAL

Guía la toracocentesis.

1.05.4.003	Ecografía pleural	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Consolidación: ecogénica, con broncograma.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO RESPIRATORIO **p. 52** Tema 3.1

Clase 3.1 en video

19 TEMA 3.2 · DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA PLEURAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

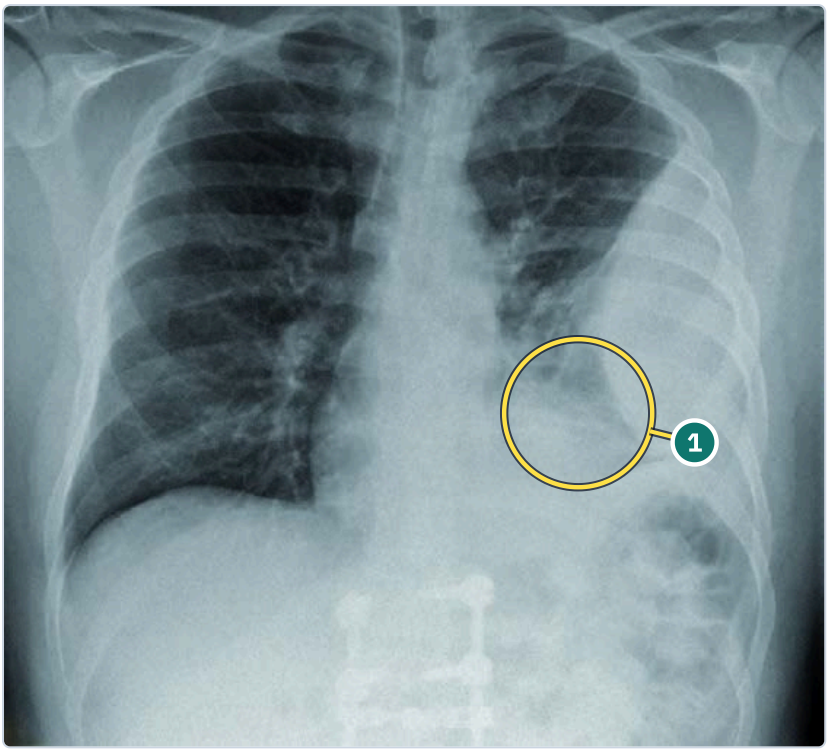


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

QUÉ TIENES QUE VER

1. Opacidad pleural encapsulada

DIAGNÓSTICO

Derrame encapsulado

Derrame que no se mueve con los cambios de posición: fase fibrinopurulenta.

CONDUCTA INICIAL

Tabicaciones que no drenan: fibrinolíticos intrapleurales o VATS.

`1.05.1.011` Derrame pleural paraneumónico complicado

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame libre: se desplaza en decúbito.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P156 «Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y…» → **Realizar drenaje completo del derrame pleural**

TOMO RESPIRATORIO **p. 56** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

20 TEMA 3.2 · DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA PLEURAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

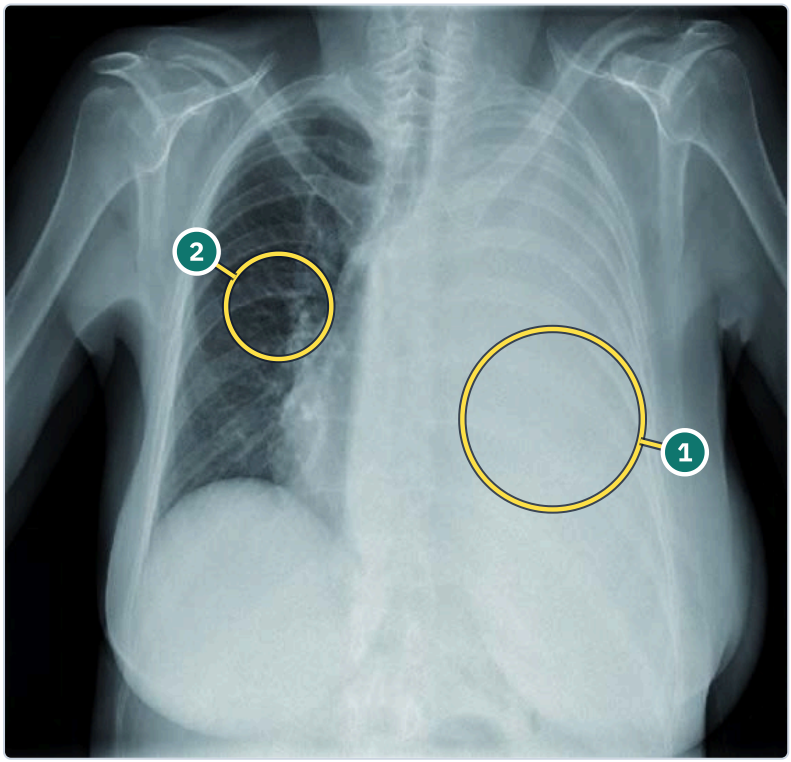


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hemitórax izquierdo opaco
2. Mediastino desplazado a la derecha

DIAGNÓSTICO

Derrame pleural masivo izquierdo

Hemitórax blanco con el mediastino empujado al lado contrario.

CONDUCTA INICIAL

Derrame paraneumónico complicado o empiema: tubo pleural.

`1.05.1.011` Derrame pleural paraneumónico complicado

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Atelectasia total: mediastino hacia el mismo lado.

PREGUNTA REAL

Julio 2018 · P49 «Un paciente de 27 años consulta por tos, fiebre alta, disnea y dolor torácico de tipo pleurítico. Al examen físico tiene disminución del murmullo…» → **Instalar un tubo pleural, con trampa de agua**

TOMO RESPIRATORIO **p. 56** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

21 TEMA 3.2 · DERRAME PARANEUMÓNICO Y EMPIEMA PLEURAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

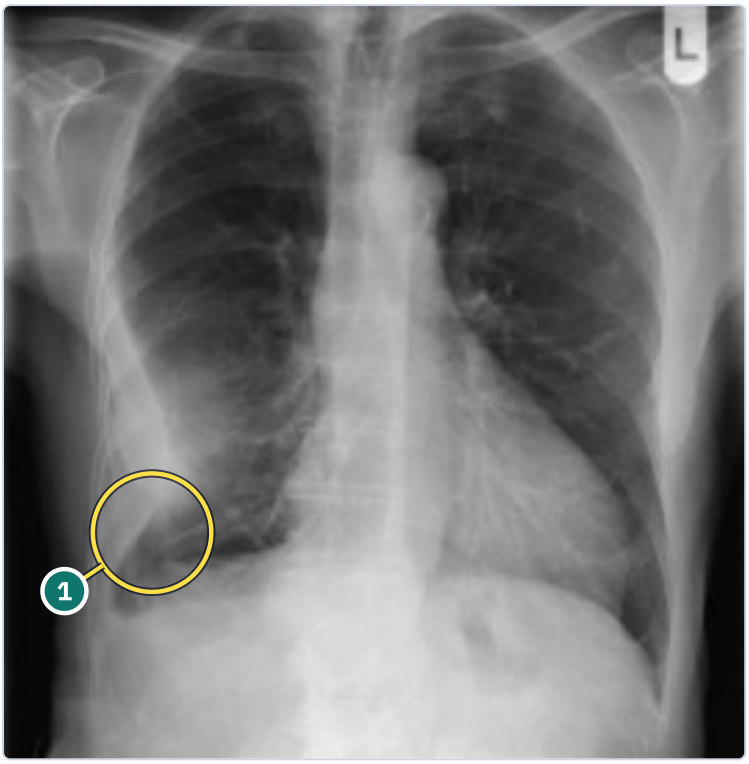


Imagen: Chest X-Ray Survival Guide, p. 98

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ángulo costofrénico borrado

DIAGNÓSTICO

Derrame pleural en la Rx de tórax

Opacidad basal que borra el ángulo costofrénico.

CONDUCTA INICIAL

Derrame paraneumónico: toracocentesis; pH < 7,20 o pus = tubo pleural.

1.05.1.011	Derrame pleural paraneumónico complicado	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Engrosamiento pleural: no se desplaza.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P156 «Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y…» → **Realizar drenaje completo del derrame pleural**

TOMO RESPIRATORIO **p. 55** Tema 3.2

Clase 3.2 en video

22 TEMA 3.3 · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO Y SECUNDARIO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 23

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pérdida de trama periférica derecha

DIAGNÓSTICO

Neumotórax: inspiración y espiración

En espiración el neumotórax se hace más evidente.

CONDUCTA INICIAL

Primario pequeño (< 2 cm): observación y oxígeno; grande o secundario: tubo.

1.05.1.031	Neumotórax moderado y grande	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Derivar
1.05.1.032	Neumotórax pequeño	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bula: sin línea pleural.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P93 «Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al…» → **Control radiológico en 24 horas**

TOMO RESPIRATORIO **p. 60** Tema 3.3

Clase 3.3 en video

23 TEMA 3.4 · NEUMOTÓRAX A TENSIÓN Y HEMOTÓRAX TRAUMÁTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

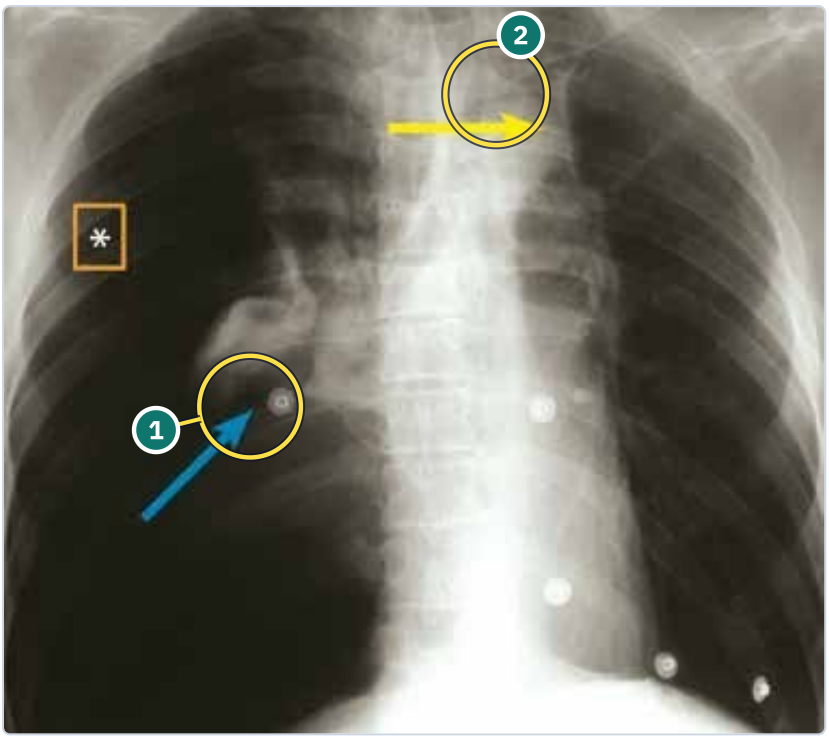


Imagen: Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 71

QUÉ TIENES QUE VER

1. Pulmón colapsado (flecha azul)
2. Mediastino desplazado (flecha amarilla)

DIAGNÓSTICO

Neumotórax a tensión

Pulmón colapsado sobre el hilio con el mediastino desplazado.

CONDUCTA INICIAL

Diagnóstico clínico: descompresión con aguja sin esperar la radiografía; luego tubo.

`1.05.2.011` Neumotórax hipertensivo — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Hemotórax masivo: matidez y yugulares colapsadas.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 62** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

24 TEMA 3.4 · NEUMOTÓRAX A TENSIÓN Y HEMOTÓRAX TRAUMÁTICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

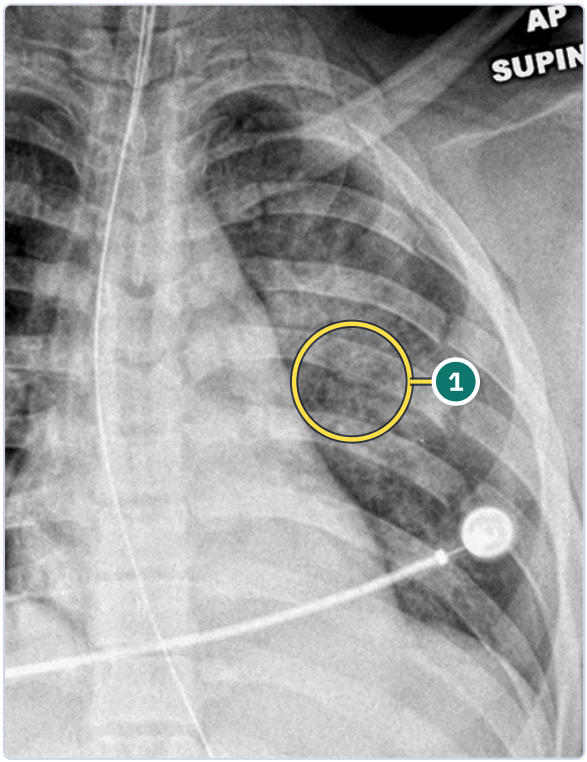


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 352

QUÉ TIENES QUE VER

1. Fracturas costales (flechas)

DIAGNÓSTICO

Tórax volante

Fracturas costales múltiples segmentarias con respiración paradójica.

CONDUCTA INICIAL

Analgesia, oxígeno y ventilación si hay insuficiencia respiratoria; buscar contusión pulmonar.

`1.05.2.013` Traumatismo torácico grave — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fractura costal única: sin segmento volante.

PREGUNTA REAL — **Julio 2024 · P102** «Una paciente de 56 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de alta energía. Presenta múltiples lesiones,...» → **Pleurostomía izquierda**

TOMO RESPIRATORIO **p. 62** Tema 3.4

Clase 3.4 en video

25 TEMA 3.5 · DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO Y PLEURITIS TUBERCULOSA

IMAGEN RADIOLÓGICA

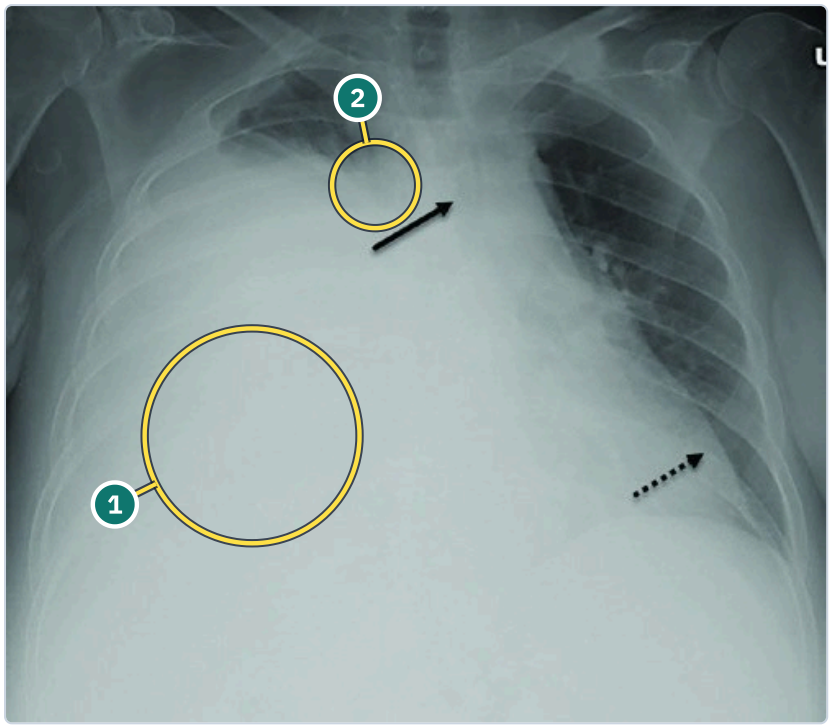


Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 99

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hemitórax opaco
2. Mediastino desplazado (flecha)

DIAGNÓSTICO

Derrame pleural masivo

Hemitórax opaco con desplazamiento del mediastino al lado contrario.

CONDUCTA INICIAL

Toracocentesis evacuadora; en neoplasia, citología y pleurodesis.

1.05.1.010	Derrame pleural neoplásico

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Atelectasia total: tira el mediastino hacia el mismo lado.

PREGUNTA REAL — **Julio 2013 · P120** «Paciente de 65 años de edad, fumador de 40 paquetes/año, consulta por disnea progresiva asociada a tos con expectoración escasa mucosa. Al examen…» → **Derrame pleural maligno**

TOMO RESPIRATORIO p. 68 Tema 3.5

Clase 3.5 en video

26 TEMA 3.5 · DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO Y PLEURITIS TUBERCULOSA

IMAGEN RADIOLÓGICA

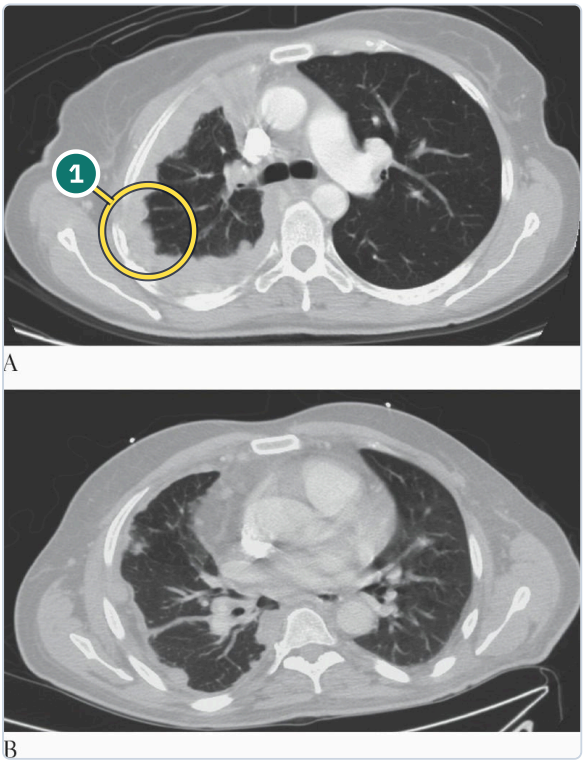


Imagen: CT and MRI Pathology atlas, p. 242

QUÉ TIENES QUE VER

1. Engrosamiento pleural lobulado

DIAGNÓSTICO

Mesotelioma pleural

Engrosamiento pleural lobulado que rodea el pulmón; exposición a asbesto.

CONDUCTA INICIAL

Biopsia pleural por videotoracoscopía.

4.01.1.042	Mesotelioma pleural

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.05.1.010	Derrame pleural neoplásico

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Derrame neoplásico metastásico.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2025 · P176** «Un paciente de 45 años consulta por disnea de 2 meses de evolución que ha ido en aumento y se ha asociado a dolor torácico en el hemitórax…» → **Mesotelioma maligno**

TOMO RESPIRATORIO p. 67 Tema 3.5

Clase 3.5 en video

27 TEMA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

IMAGEN RADIOLÓGICA

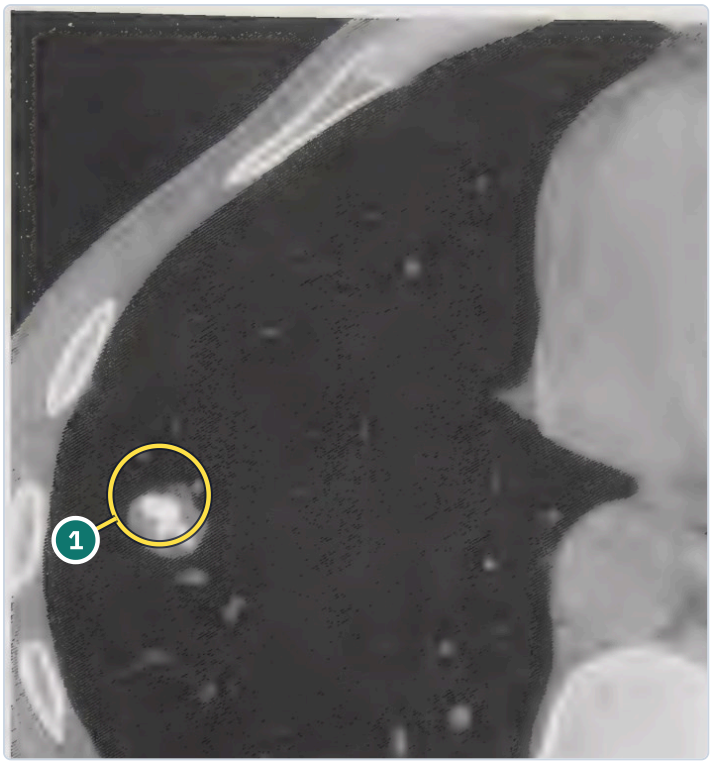


Imagen: Brant y Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 461

QUÉ TIENES QUE VER

1 Calcificación en popcorn

DIAGNÓSTICO

Hamartoma: calcificación en palomitas de maíz

Calcificación en popcorn con grasa: patognomónica de hamartoma.

CONDUCTA INICIAL

Benigno: no requiere estudio adicional.

1.05.1.038	Nódulos pulmonares	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nódulo espiculado: sospecha de cáncer.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 74** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

28 TEMA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

IMAGEN RADIOLÓGICA

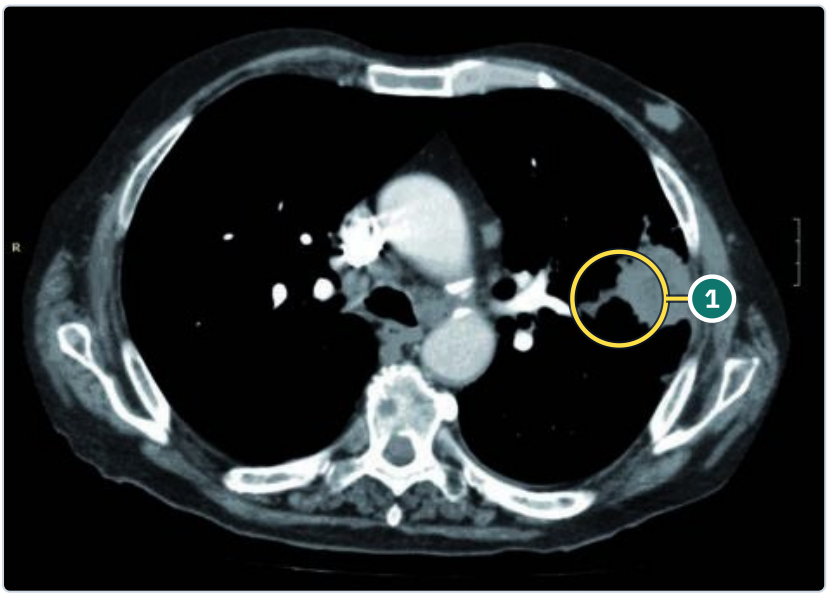


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 139

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa de bordes irregulares

DIAGNÓSTICO

Masa pulmonar de bordes irregulares

Bordes espiculados: sugieren cáncer.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste y estudio histológico.

1.05.1.038	Nódulos pulmonares	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.05.1.007	Cáncer bronquial primario	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Neumonía redonda: resuelve con antibiótico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 74** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

29 TEMA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

IMAGEN RADIOLÓGICA

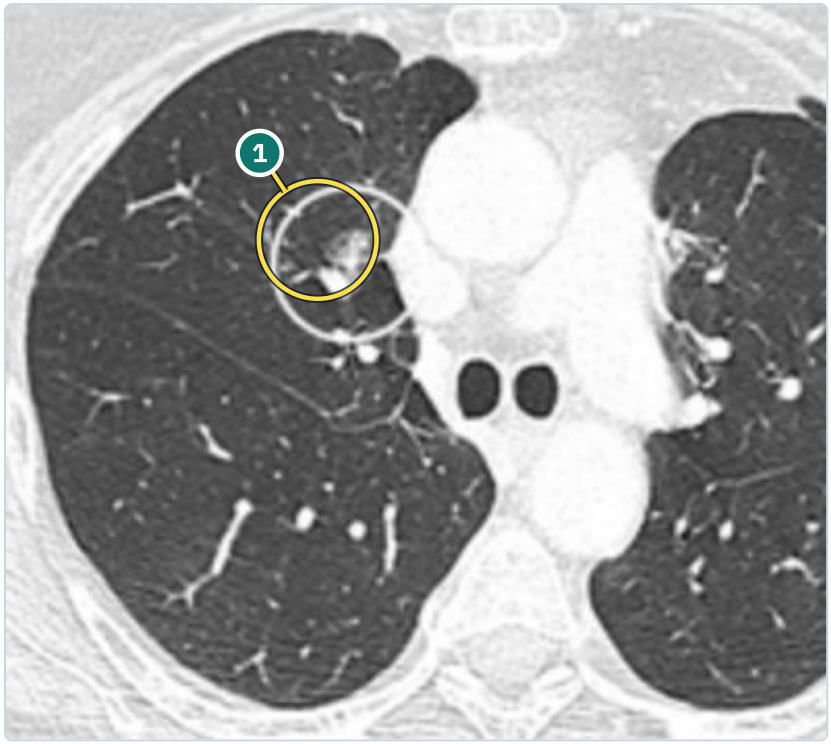


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo subsólido (círculo)

DIAGNÓSTICO

Nódulo parcialmente sólido

Parte sólido y parte en vidrio esmerilado: sugiere malignidad.

CONDUCTA INICIAL

Seguimiento con TAC según Fleischner o resección.

1.05.1.038	Nódulos pulmonares	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
1.05.4.002	TAC de tórax	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Nódulo calcificado benigno.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO RESPIRATORIO **p. 74** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

30 TEMA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Herring, Learning Radiology, 4.ª ed., p. 138

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo de bordes espiculados

DIAGNÓSTICO

Nódulo pulmonar espiculado

Bordes espiculados, > 8 mm y en lóbulo superior: alta sospecha de cáncer.

CONDUCTA INICIAL

Comparar con imágenes previas; PET-CT o biopsia según riesgo.

1.05.1.038	Nódulos pulmonares	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.038	Nódulo pulmonar solitario	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hamartoma: liso con calcificación en popcorn.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P139 «Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se…» → **Solicitar TAC de tórax**

TOMO RESPIRATORIO **p. 74** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

31 TEMA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO (NPS)

IMAGEN RADIOLÓGICA

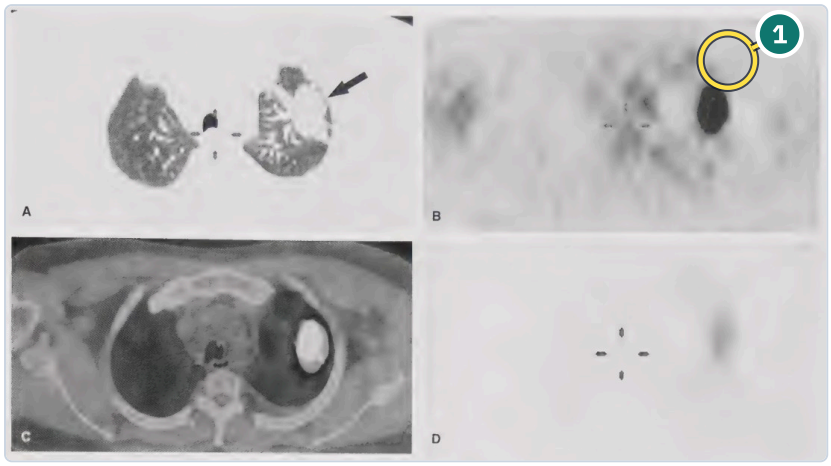


Imagen: Brant y Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 1547

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulo hipercaptante

DIAGNÓSTICO

PET-CT: nódulo hipercaptante

El nódulo consume glucosa como un tumor.

CONDUCTA INICIAL

Riesgo intermedio y > 8 mm: PET-CT; si capta, biopsia o resección.

1.05.1.038 **Nódulos pulmonares**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Granuloma inflamatorio: también puede captar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 74** Tema 4.1

Clase 4.1 en video

32 TEMA 4.2 · CÁNCER PULMONAR

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

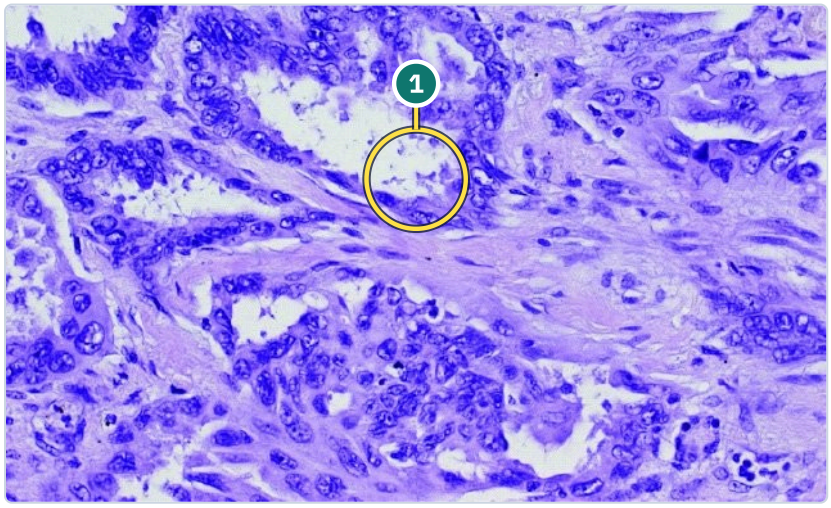


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 125

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estructuras glandulares

DIAGNÓSTICO

Adenocarcinoma de pulmón

Forma glándulas; el más frecuente, periférico, también en no fumadores.

CONDUCTA INICIAL

Resecable (I-II): lobectomía.

1.05.1.007 **Cáncer bronquial primario**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Epidermoide: puentes y queratina, central.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 78** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

33 TEMA 4.2 · CÁNCER PULMONAR

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

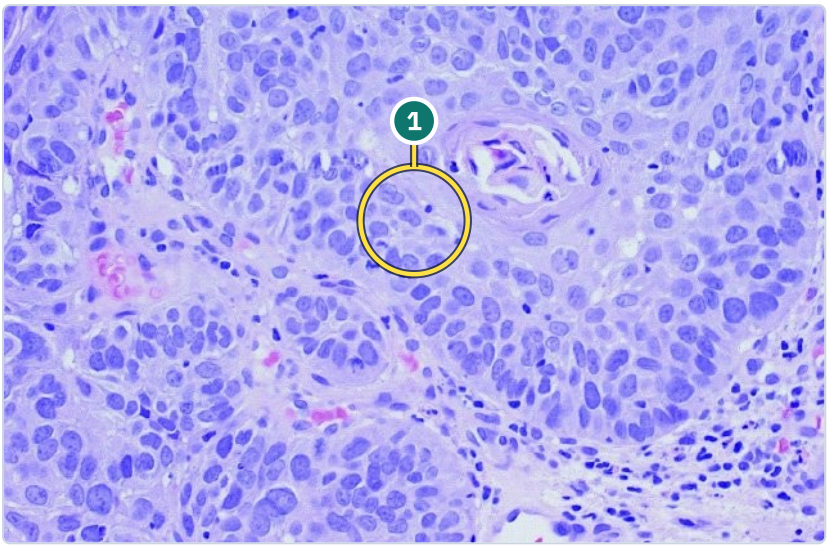


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 125

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nidos de células escamosas

DIAGNÓSTICO

Carcinoma epidermoide

Puentes intercelulares y queratina; central, cavita y da hipercalcemia (PTHrP).

CONDUCTA INICIAL

Masa hiliar cavitada en fumador: piensa en epidermoide.

1.05.1.007	Cáncer bronquial primario	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Microcítico: central, no quirúrgico, SIADH.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 78** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

34 TEMA 4.2 · CÁNCER PULMONAR

FOTO CLÍNICA

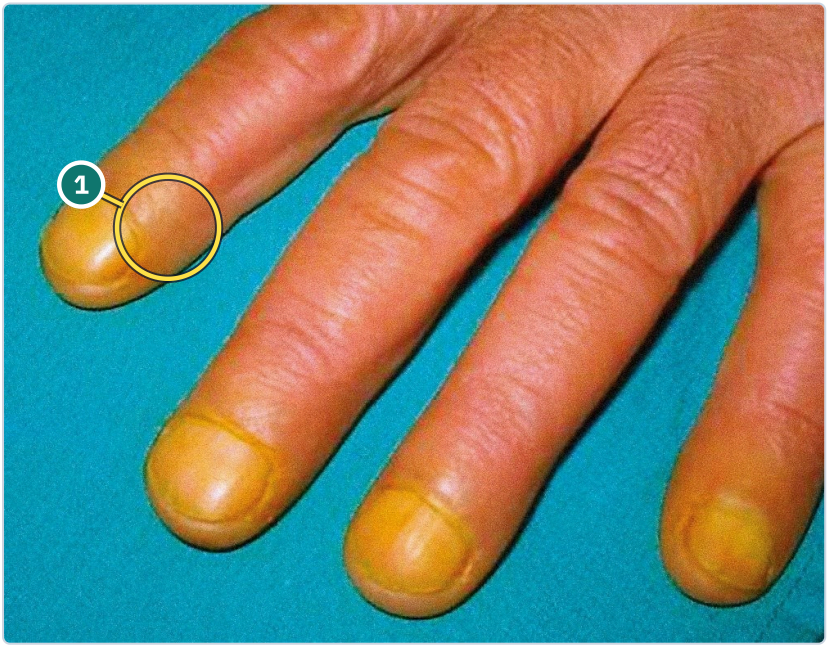


Imagen: Manual AMIR Reumatología, p. 113

QUÉ TIENES QUE VER

1 Uñas en vidrio de reloj y pulpejo engrosado

DIAGNÓSTICO

Acropaquias (dedos en palillo de tambor)

Osteoartropatía hipertrófica pulmonar asociada al adenocarcinoma.

CONDUCTA INICIAL

Acropaquia nueva en fumador: radiografía de tórax.

1.05.1.007	Cáncer bronquial primario	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
1.08.1.016	Síndrome paraneoplásico	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Uñas normales: ángulo de Lovibond conservado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 78** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

35 TEMA 4.2 · CÁNCER PULMONAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

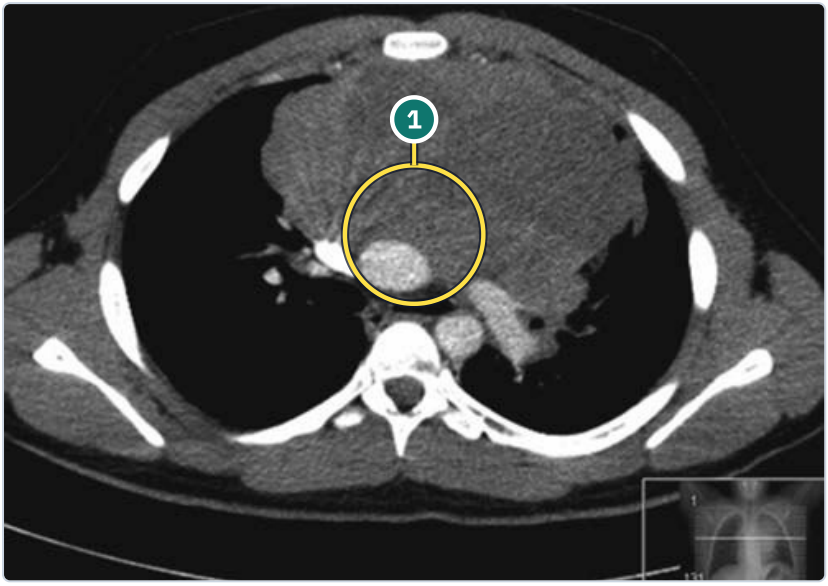


Imagen: Kumar & Clark's Clinical Medicine, p. 307

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa mediastínica

DIAGNÓSTICO

Síndrome de vena cava superior en la TAC

Masa mediastínica que comprime la vena cava superior.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste y biopsia; microcítico: quimio o radioterapia urgente.

1.08.2.008 Síndrome vena cava superior

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aneurisma aórtico: realza como la aorta.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P66 «Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a…» → **Realizar radioterapia de urgencia**

TOMO RESPIRATORIO **p. 78** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

36 TEMA 4.2 · CÁNCER PULMONAR

FOTO CLÍNICA

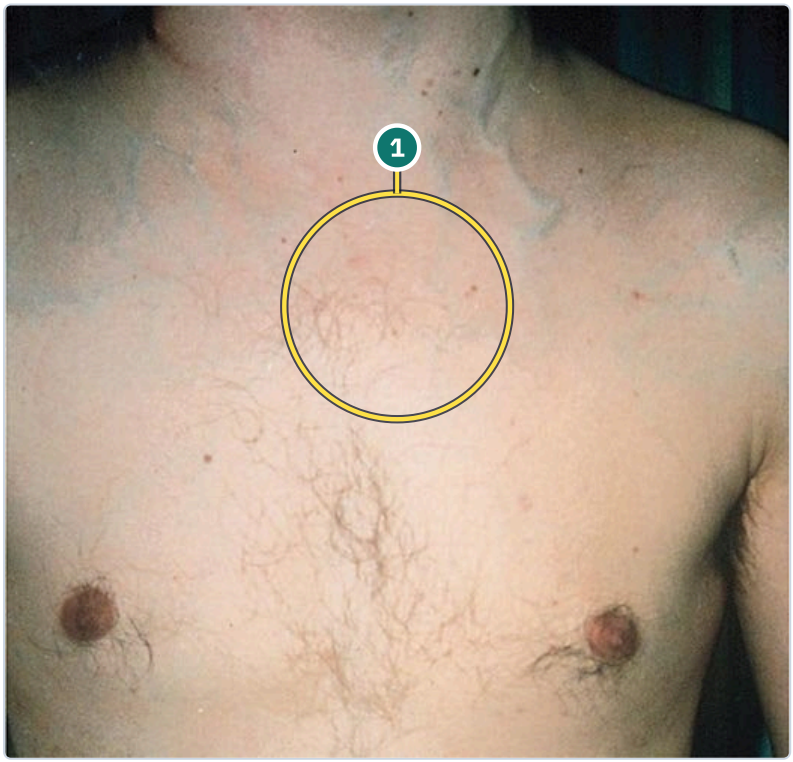


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 193

QUÉ TIENES QUE VER

1 Circulación colateral torácica

DIAGNÓSTICO

Síndrome de vena cava superior

Venas colaterales dilatadas en el tórax con edema en esclavina.

CONDUCTA INICIAL

TAC con contraste; microcítico: radioterapia o quimioterapia urgente.

1.08.2.008 Síndrome vena cava superior

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cabeza de medusa: periumbilical.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P66 «Un paciente de 75 años, con diagnóstico de cáncer de células pequeñas, presenta un cuadro de 2 días de aumento de volumen de la cara, asociado a…» → **Realizar radioterapia de urgencia**

TOMO RESPIRATORIO **p. 80** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

37 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (EPID) Y FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

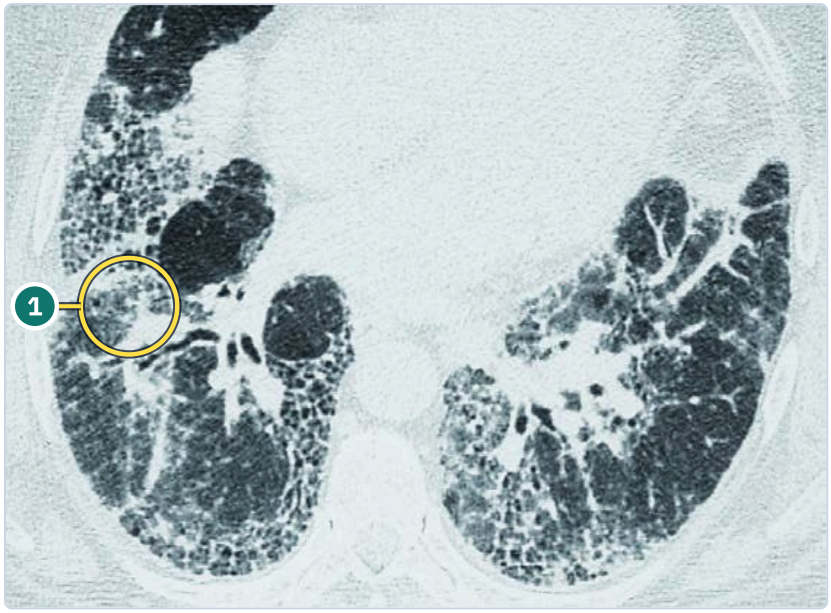


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 73

QUÉ TIENES QUE VER

1 Panal de abejas subpleural

DIAGNÓSTICO

Fibrosis pulmonar idiopática: panal de abejas

Patrón NIU con panal de abejas subpleural y basal.

CONDUCTA INICIAL

NIU típico en > 60 años: no requiere biopsia; pirfenidona o nintedanib; corticoides contraindicados.

1.05.1.018 Enfermedades del intersticio pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

NINE: vidrio esmerilado sin panal.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P38** «Una paciente de 58 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, consulta por un cuadro de 2 años de evolución de disnea…» → **Fibrosis pulmonar idiopática**

TOMO RESPIRATORIO p. 82 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

38 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (EPID) Y FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

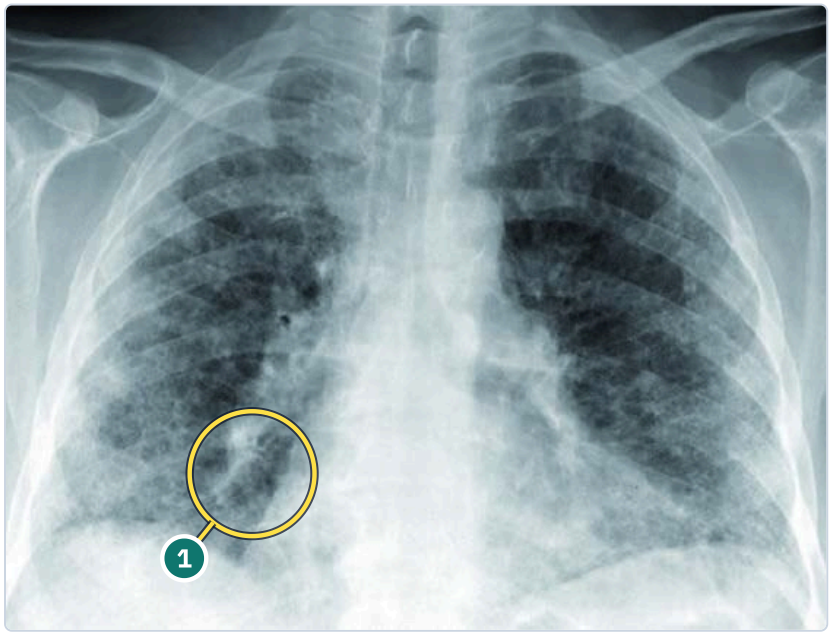


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 73

QUÉ TIENES QUE VER

1 Reticulación basal bilateral

DIAGNÓSTICO

Fibrosis pulmonar en la radiografía

Patrón reticular de predominio basal con volúmenes reducidos.

CONDUCTA INICIAL

Crepitantes tipo velcro + acropaquia: TACAR.

1.05.1.018 Enfermedades del intersticio pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Edema intersticial: cardiomegalia y Kerley.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P98** «Un paciente de 62 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida y fumador de 5 paquetes año,…» → **Fibrosis pulmonar idiopática**

TOMO RESPIRATORIO p. 82 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

39 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (EPID) Y FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3338

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vidrio esmerilado subpleural (flechas)

DIAGNÓSTICO

NINE: vidrio esmerilado

Vidrio esmerilado subpleural bilateral que respeta la franja bajo la pleura.

CONDUCTA INICIAL

Patrón de esclerodermia, lupus y artritis reumatoide.

1.05.1.018 Enfermedades del intersticio pulmonar

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

FPI: panal de abejas.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P64 «Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros…» → **Enfermedad pulmonar intersticial difusa**

TOMO RESPIRATORIO **p. 82** Tema 4.3

Clase 4.3 en video

40 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (EPID) Y FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

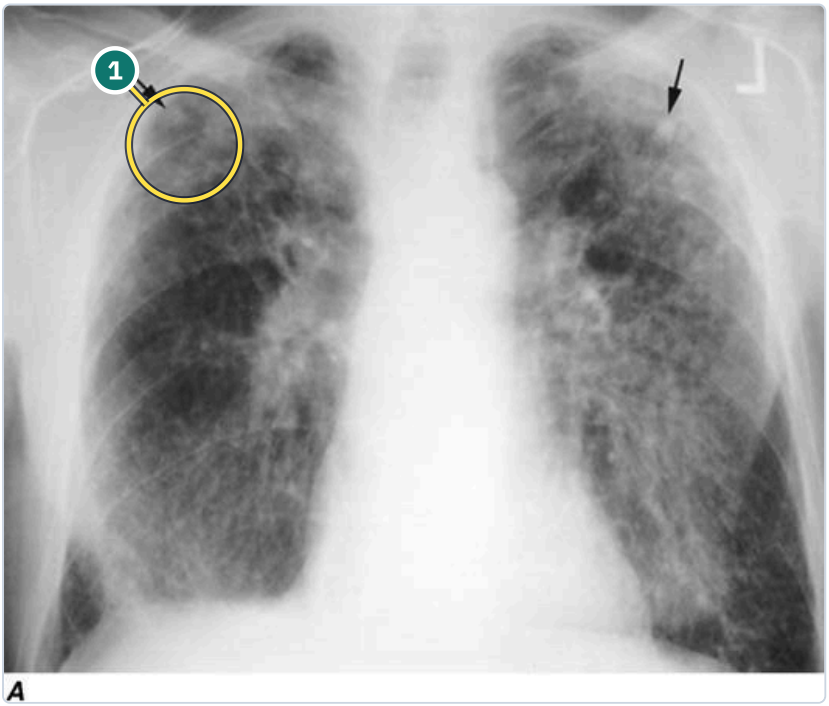


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, p. 2210

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nódulos en los lóbulos superiores (flechas)

DIAGNÓSTICO

Silicosis crónica

Nódulos mal definidos de predominio en los lóbulos superiores.

CONDUCTA INICIAL

Exposición laboral (minería): retirar de la exposición.

1.05.1.026 Neumoconiosis

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

TBC: cavitación; ambas se asocian.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P89 «Trabajador de la minería, fumador leve, con disnea, sibilancias, hiperinsuflación y espirometría obstructiva no reversible. ¿Diagnóstico más probable?» → **Silicosis pulmonar**

TOMO RESPIRATORIO **p. 82** Tema 4.3

Clase 4.3 en video

41 TEMA 4.3 · ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS (EPID) Y FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

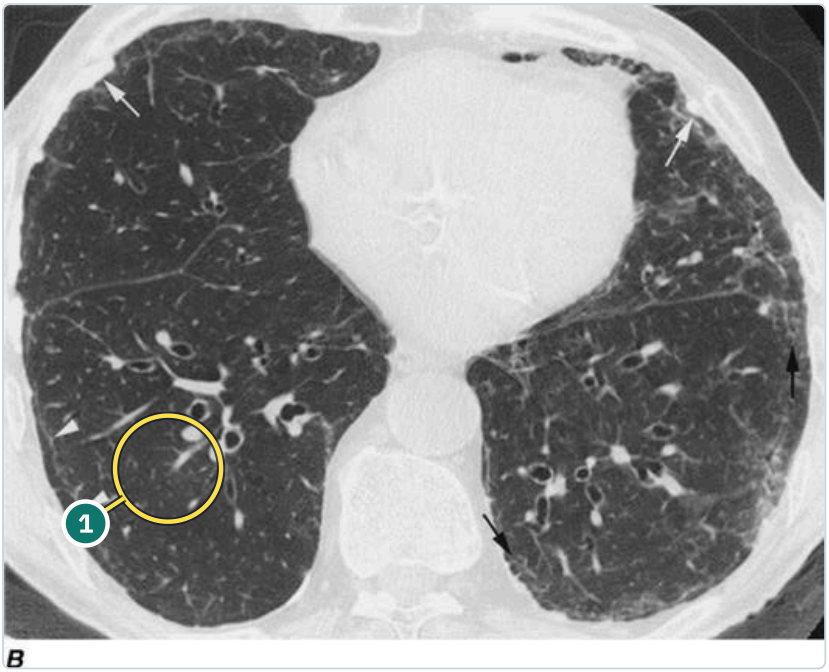


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, p. 2209

QUÉ TIENES QUE VER

1 Reticulación subpleural

DIAGNÓSTICO

Asbestosis en la TACAR

Reticulación subpleural basal con placas pleurales.

CONDUCTA INICIAL

Más riesgo de mesotelioma y cáncer pulmonar, sobre todo si fuma.

1.05.1.026 Neumoconiosis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

FPI: sin placas pleurales.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 82 Tema 4.3

Clase 4.3 en video

42 TEMA 4.4 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pierna derecha aumentada de volumen

DIAGNÓSTICO

Trombosis venosa profunda

Pierna más hinchada con la vena marcada: origen de > 90% de los TEP.

CONDUCTA INICIAL

Eco-Doppler; anticoagulación.

1.05.1.015 Embolia pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Celulitis: placa eritematosa caliente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 86 Tema 4.4

Clase 4.4 en video

43 TEMA 4.4 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

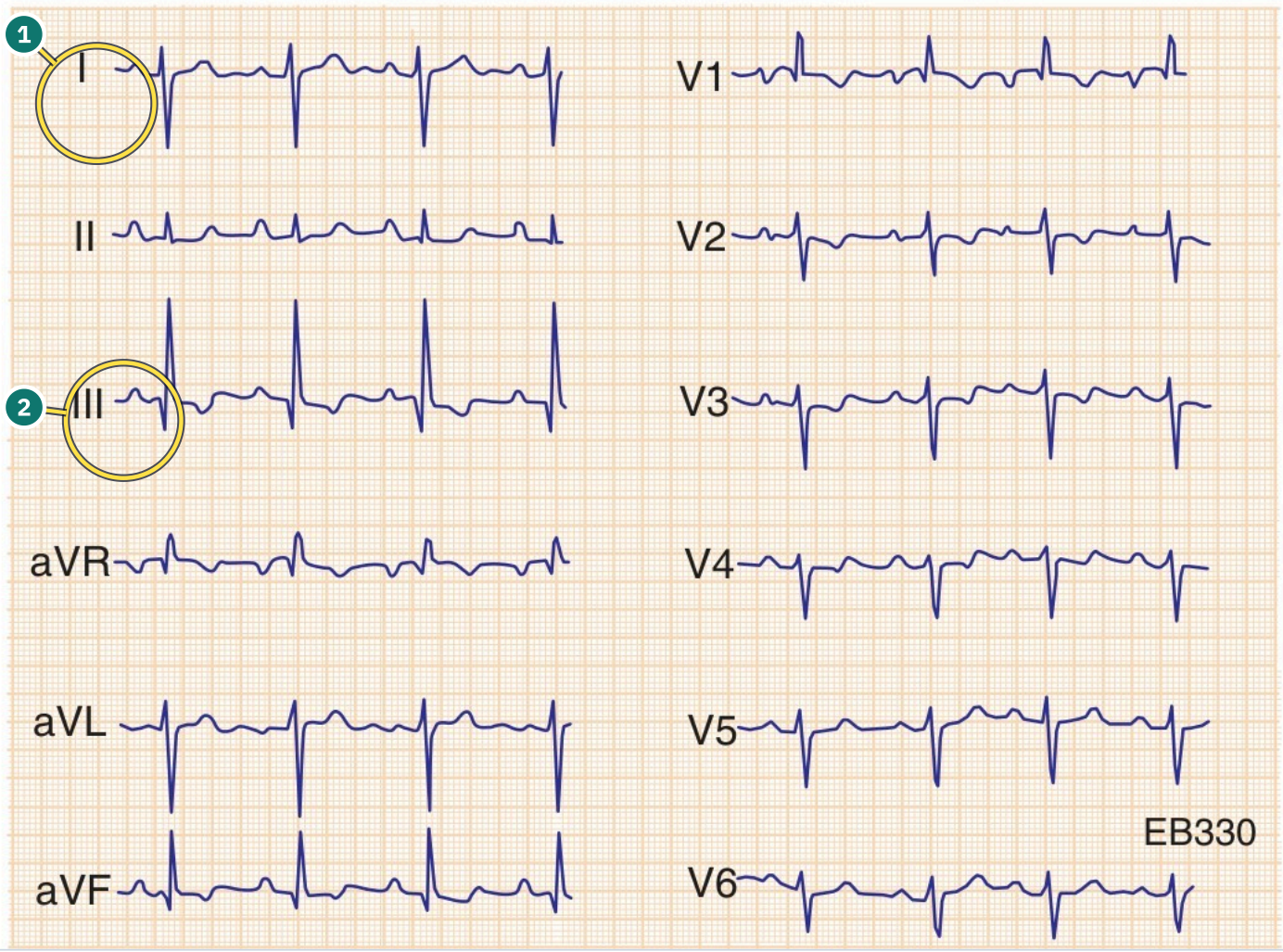


Imagen: ECG from Basics to Essentials, p. 195

QUÉ TIENES QUE VER

1. S en DI
2. Q y T negativa en DIII

DIAGNÓSTICO

ECG en TEP: S1Q3T3

S profunda en DI, Q y T invertida en DIII: específico pero en < 15-20%.

CONDUCTA INICIAL

Lo más frecuente es la taquicardia sinusal; el examen es el angioTAC.

1.05.1.015 Embolia pulmonar

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infarto inferior: supradesnivel en DII, DIII y aVF.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 86 Tema 4.4

Clase 4.4 en video

44 TEMA 4.4 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO

IMAGEN RADIOLÓGICA

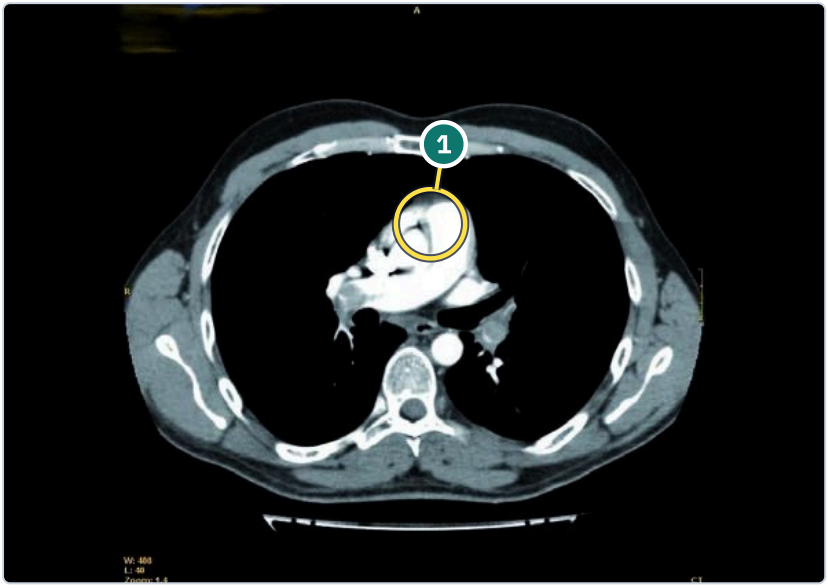


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 103

QUÉ TIENES QUE VER

1 Émbolo en la arteria pulmonar

DIAGNÓSTICO

AngioTAC: defecto de llenado

Defecto de llenado en las arterias pulmonares: el émbolo.

CONDUCTA INICIAL

Wells > 4: angioTAC directo; ≤ 4: dímero D primero.

1.05.1.015	Embolia pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.4.010	TAC de tórax — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Artefacto de flujo.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P21** «Un paciente de 55 años, está hospitalizado por una pancreatitis aguda, de diez días de evolución. Presenta un cuadro de fiebre, malestar general…» → **Solicitar angioTAC de tórax**

TOMO RESPIRATORIO **p. 86** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

45 TEMA 4.4 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO

ECOGRAFÍA

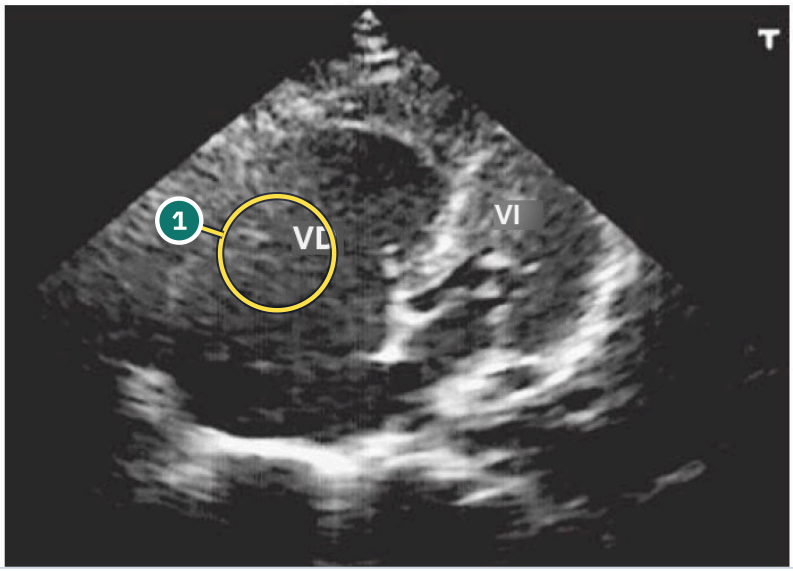


Imagen: Reardon y Ma, Pocket Atlas of Emergency Ultrasound, p. 104

QUÉ TIENES QUE VER

1 VD mayor que el VI

DIAGNÓSTICO

Ecocardiograma: VD dilatado

Ventrículo derecho dilatado: disfunción en el TEP de riesgo intermedio-alto.

CONDUCTA INICIAL

TEP masivo con shock: trombólisis (alteplasa 100 mg en 2 h).

1.05.2.005	Embolia pulmonar masiva — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipertensión pulmonar crónica: pared del VD hipertrófica.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P99** «Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral….» → **Ecocardiograma**

TOMO RESPIRATORIO **p. 85** Tema 4.4

Clase 4.4 en video

46 TEMA 4.5 · HEMOPTISIS Y BRONQUIECTASIAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

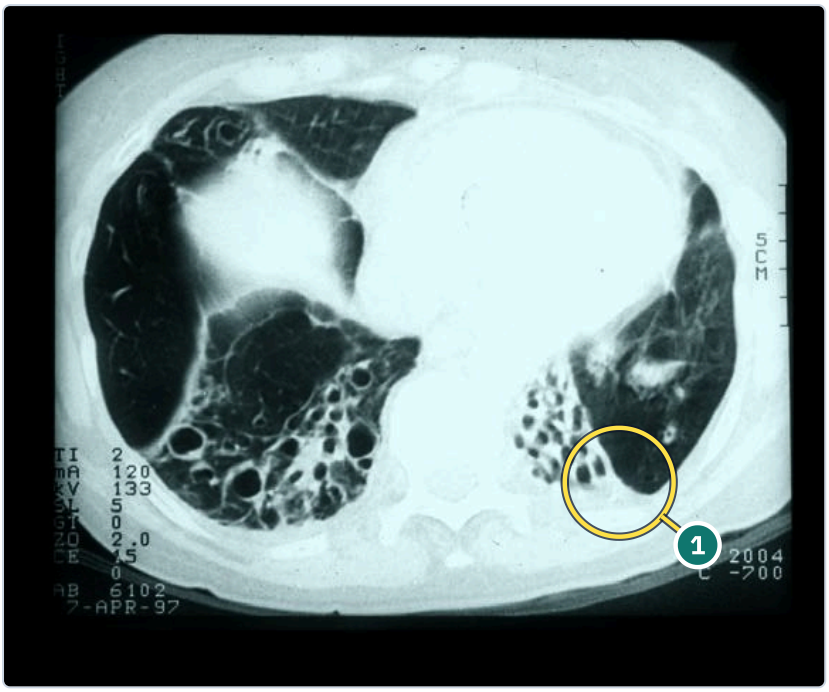


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 68

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bronquios dilatados

DIAGNÓSTICO

Bronquiectasias

Bronquios más anchos que la arteria que los acompaña (anillo de sello).

CONDUCTA INICIAL

TACAR confirma; kinesioterapia y antibióticos en exacerbaciones.

1.05.1.004 Bronquiectasias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Enfisema: espacios sin pared.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P9 «Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repetición y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y productiva,...» → **Bronquiectasias**

TOMO RESPIRATORIO p. 91 Tema 4.5

Clase 4.5 en video

47 TEMA 4.5 · HEMOPTISIS Y BRONQUIECTASIAS

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 2216

QUÉ TIENES QUE VER

1 Bronquios quísticos dilatados

DIAGNÓSTICO

Bronquiectasias graves

Bronquios dilatados en corte longitudinal y transversal.

CONDUCTA INICIAL

Fibrosis quística en jóvenes: test del sudor.

1.05.1.004 Bronquiectasias — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Panal de abejas: subpleural y basal.

PREGUNTA REAL

Enero 2023 · P87 «Paciente con infecciones respiratorias recurrentes y expectoración matinal de 200 mL al día. ¿Cuál es el examen de elección para el estudio?» → **TAC de tórax de alta resolución**

TOMO RESPIRATORIO p. 91 Tema 4.5

Clase 4.5 en video

48 TEMA 5.2 · SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

IMAGEN RADIOLÓGICA

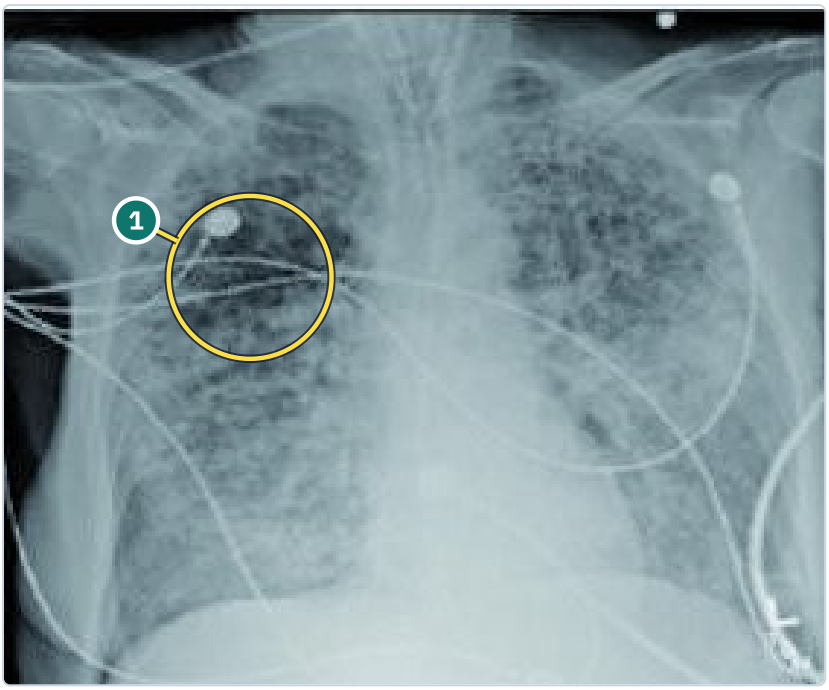


Imagen: Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 35

QUÉ TIENES QUE VER

1. Infiltrado alveolar bilateral

DIAGNÓSTICO

Síndrome de distrés respiratorio agudo

Opacidades bilaterales que no se explican por derrame, atelectasia ni nódulos.

CONDUCTA INICIAL

Volumen corriente 6 mL/kg de peso ideal, meseta ≤ 30; prono si PaFi < 150.

1.05.1.014	Edema pulmonar no cardiogénico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.05.5.011	Ventilación mecánica invasiva	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Edema cardiogénico: cardiomegalia y respuesta al diurético.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 103** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

49 TEMA 5.2 · SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

IMAGEN RADIOLÓGICA

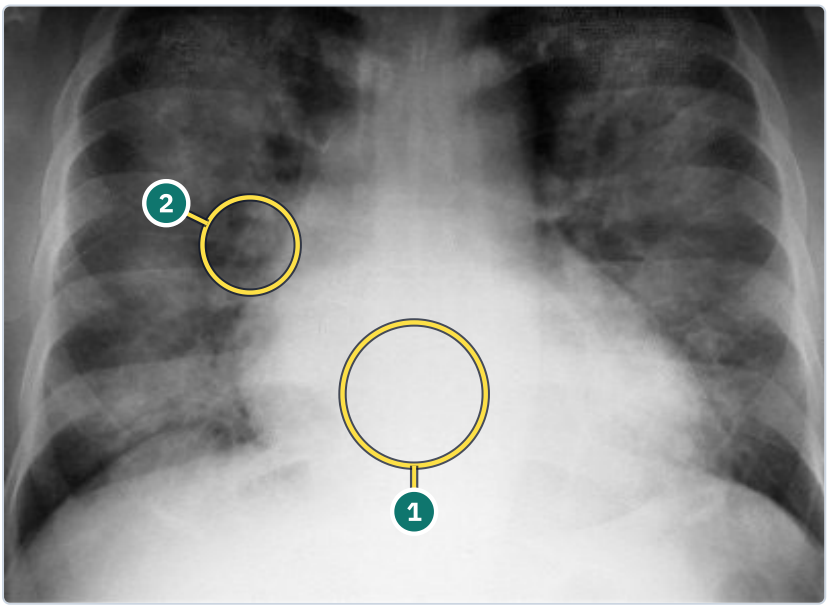


Imagen: Atlas EUNACOM 2026

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cardiomegalia
2. Congestión perihiliar

DIAGNÓSTICO

Edema pulmonar cardiogénico

Edema con corazón grande.

CONDUCTA INICIAL

Furosemida, nitroglicerina y CPAP.

1.05.1.014	Edema pulmonar no cardiogénico	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

SDRA: corazón normal, no responde al diurético.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 103** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

50 TEMA 5.2 · SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

IMAGEN RADIOLÓGICA

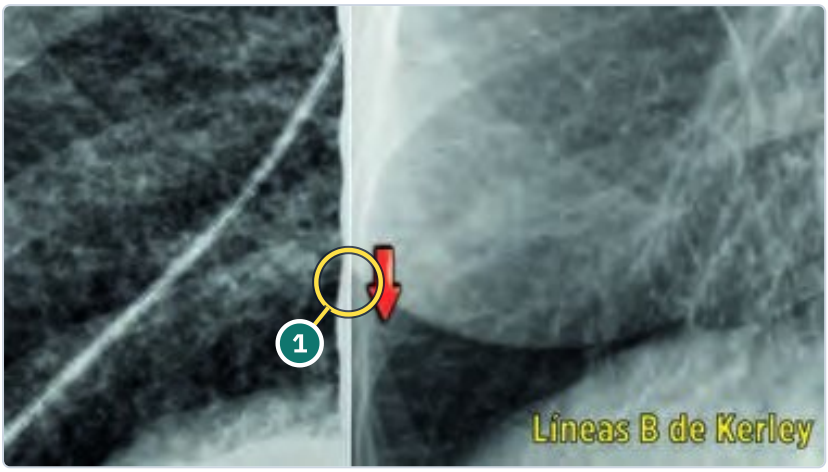


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 11

QUÉ TIENES QUE VER

1. Líneas B de Kerley (flecha)

DIAGNÓSTICO

Líneas B de Kerley

Líneas septales cortas en la base: edema intersticial por presión.

CONDUCTA INICIAL

Edema hidrostático: diurético de asa y vasodilatador.

1.05.1.014 **Edema pulmonar no cardiogénico**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Fibrosis: reticulado fijo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 103** Tema 5.2

Clase 5.2 en video

51 TEMA 5.3 · SÍNDROME DE APNEA-HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS)

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

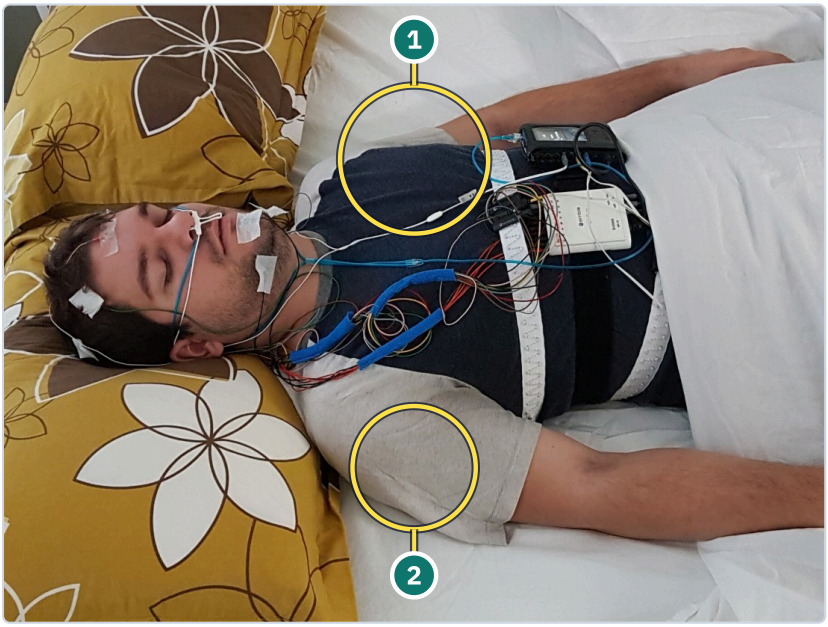


Imagen: Wikimedia Commons «Polysomnography model.jpg», CC BY-SA 4.0, Clinique Somnomed

QUÉ TIENES QUE VER

1. Canales de flujo y esfuerzo
2. Saturación de oxígeno

DIAGNÓSTICO

Polisomnografía

Registro nocturno de flujo, esfuerzo, saturación, ECG y EEG.

CONDUCTA INICIAL

IAH ≥ 15: CPAP nasal nocturno.

1.05.1.033 **Síndrome de apnea del sueño**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

6.03.4.009 **Polisomnografía**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Poligrafía respiratoria: alternativa ambulatoria.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P13** «Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diur- na. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las…» → **Polisomnografía**

TOMO RESPIRATORIO **p. 106** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

52 TEMA 5.3 · SÍNDROME DE APNEA-HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS)

ESQUEMA

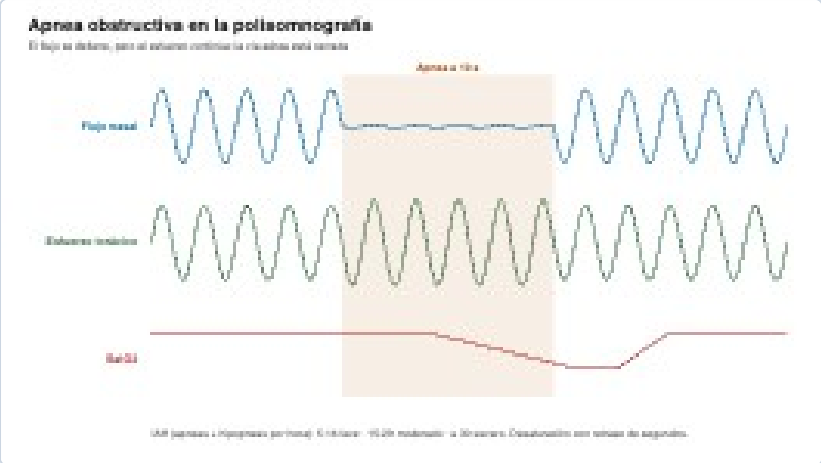


Imagen: Wikimedia Commons «Polysomnography model.jpg», CC BY-SA 4.0, Clinique Somnomed

QUÉ TIENES QUE VER

- Flujo nasal ausente ≥ 10 s
- Esfuerzo torácico mantenido
- Desaturación con retraso

DIAGNÓSTICO

Apnea obstructiva en la polisomnografía

El flujo se detiene pero el esfuerzo continúa: la vía aérea está cerrada.

CONDUCTA INICIAL

IAH ≥ 15: CPAP nasal nocturno; sedantes y alcohol contraindicados.

1.05.1.033	Síndrome de apnea del sueño	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
6.03.4.009	Polisomnografía	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Apnea central: sin esfuerzo torácico.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P13** «Un paciente de 43 años, obeso mórbido, consulta por cansancio y somnolencia diur- na. Refiere que ronca en la noche y se queda dormido en las…» → **Polisomnografía**

TOMO RESPIRATORIO **p. 106** Tema 5.3

Clase 5.3 en video

53 TEMA 5.4 · INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO E INHALACIÓN DE HUMO

ESQUEMA

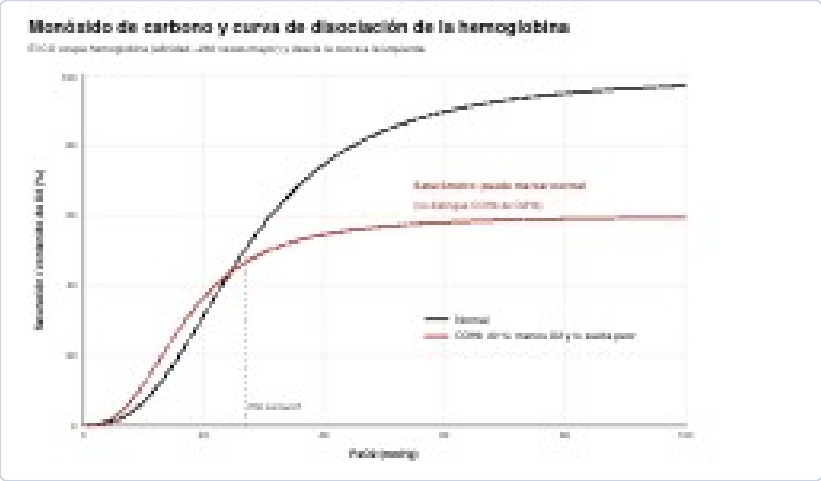


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

- El saturómetro puede marcar normal
- COHb ocupa la hemoglobina (afinidad ~240 veces)

DIAGNÓSTICO

Monóxido de carbono y curva de disociación

El CO desplaza la curva a la izquierda: la hemoglobina no entrega el oxígeno.

CONDUCTA INICIAL

Oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio; COHb por co-oximetría.

1.05.2.010	Intoxicación por monóxido de carbono	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
1.05.4.014	Saturometría arterial	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hipoxemia común: el saturómetro sí la detecta.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P10** «Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a…» → **Niveles de carboxihemoglobina**

TOMO RESPIRATORIO **p. 109** Tema 5.4

Clase 5.4 en video

54 TEMA 5.5 · AHOGAMIENTO (ASFIXIA POR INMERSIÓN) E HIPOTERMIA ACCIDENTAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

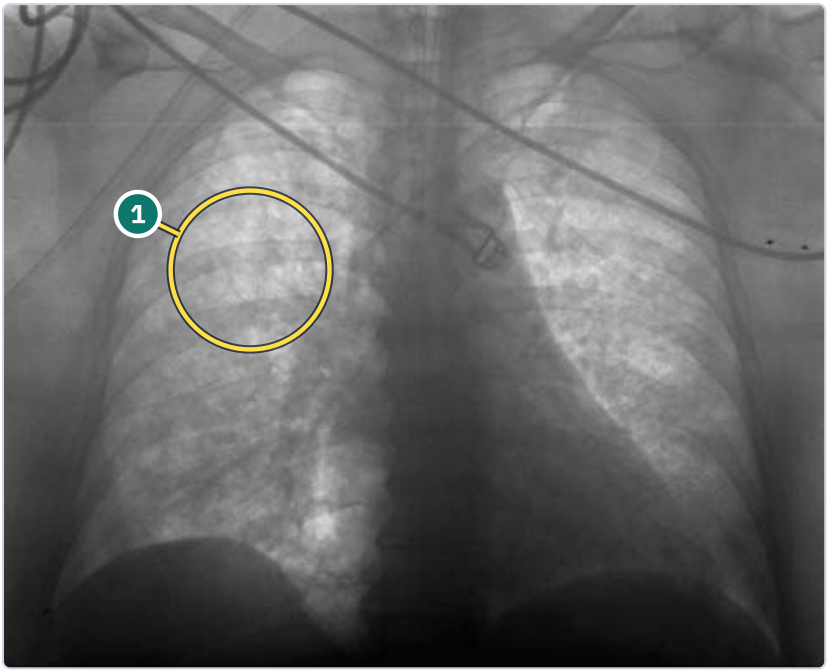


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 301-2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Opacidades bilaterales

DIAGNÓSTICO

Ahogamiento: edema pulmonar no cardiogénico

El agua lava el surfactante: opacidades bilaterales.

CONDUCTA INICIAL

Todo ahogado se observa 6-8 h; el paro es hipóxico (5 ventilaciones de rescate).

1.05.2.001 Asfixia por inmersión

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Edema cardiogénico: cardiomegalia.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO **p. 112** Tema 5.5

Clase 5.5 en video

55 TEMA 5.5 · AHOGAMIENTO (ASFIXIA POR INMERSIÓN) E HIPOTERMIA ACCIDENTAL

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

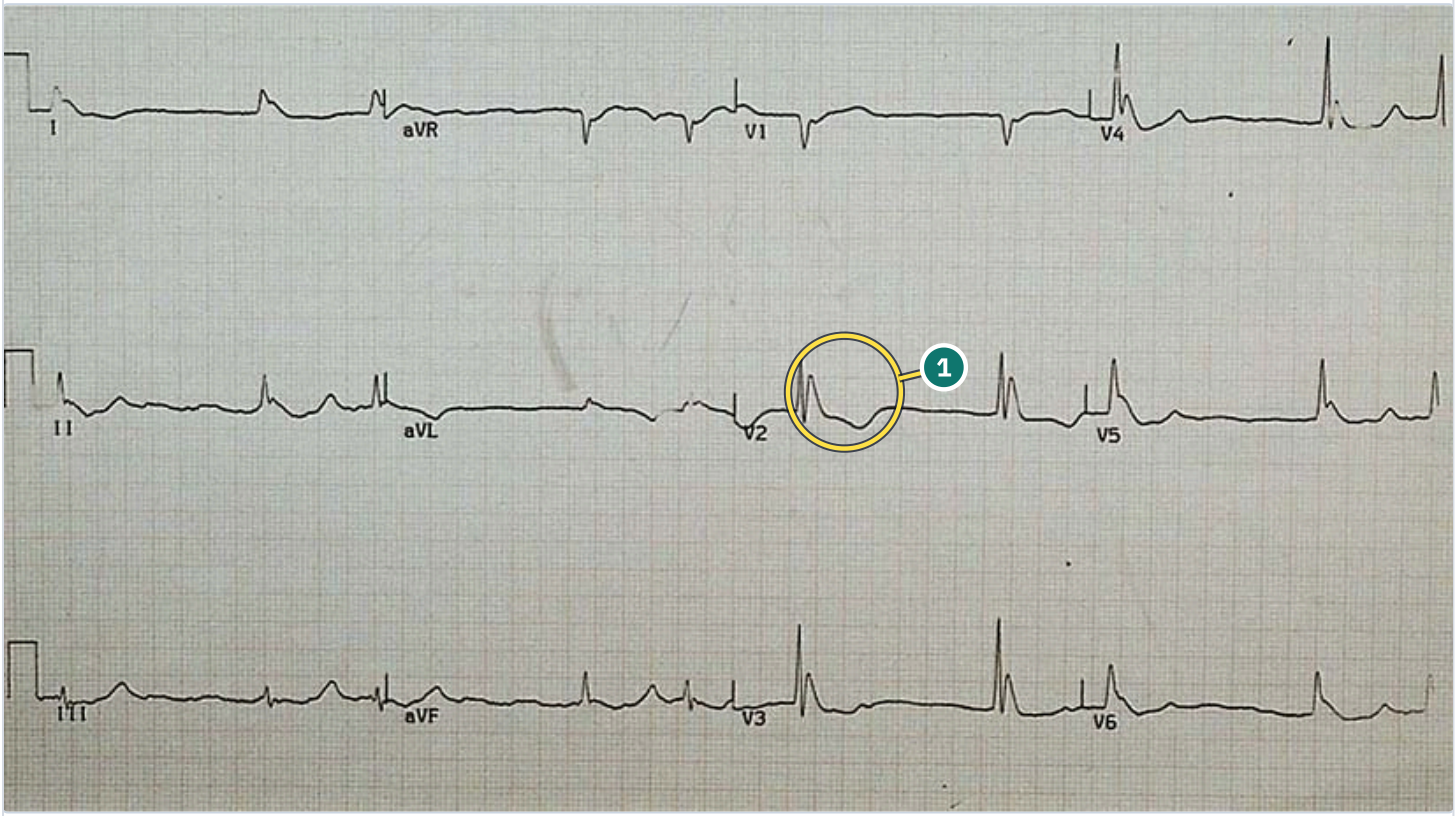


Imagen: Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 551

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda J de Osborn

DIAGNÓSTICO

Hipotermia: onda J de Osborn

Joroba al final del QRS en la hipotermia moderada a grave.

CONDUCTA INICIAL

Recalentamiento escalonado y manipulación cuidadosa (riesgo de FV).

1.07.1.011 Hipotermia

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Supradesnivel del ST isquémico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO RESPIRATORIO p. 112 Tema 5.5

Clase 5.5 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Neumonía típica vs atípica



VS



A **Neumonía: consolidación lobar**

- Consolidación lobar
- Neumococo

Ficha n.° 07 · p. 7

B **Neumonía por Mycoplasma**

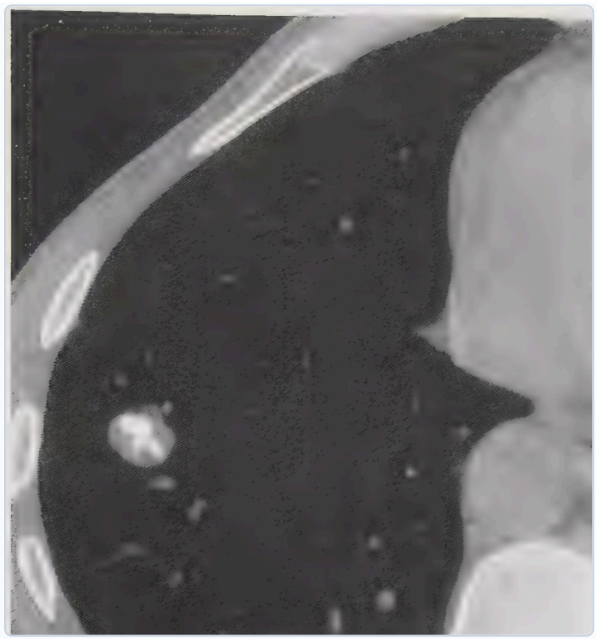
- Infiltrado intersticial perihiliar
- Disociación clínico-radiológica

Ficha n.° 09 · p. 8

LA DIFERENCIA Mycoplasma no tiene pared: no responde a betalactámicos.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Nódulo benigno vs maligno



VS



A **Hamartoma: calcificación en palomitas de maíz**

- Calcificación en popcorn

Ficha n.° 27 · p. 17

B **Nódulo pulmonar espiculado**

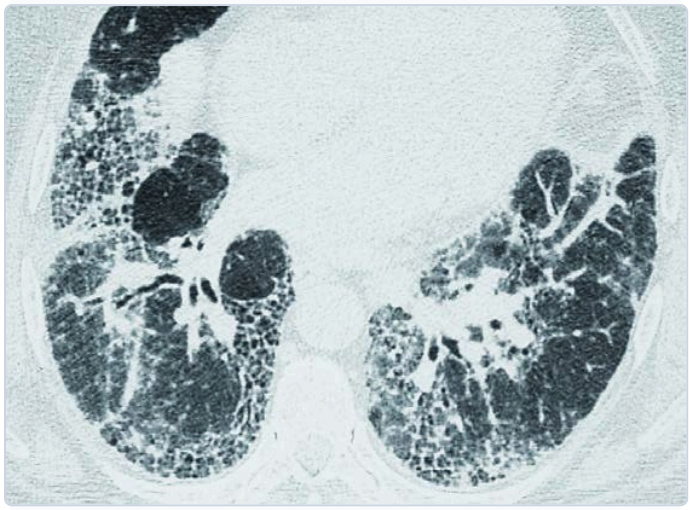
- Bordes espiculados, > 8 mm

Ficha n.° 30 · p. 18

LA DIFERENCIA El patrón del calcio y el borde orientan; la estabilidad ≥ 2 años confirma benignidad.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

FPI (NIU) vs NINE



VS



A Fibrosis pulmonar idiopática: panal de abejas

- Panal de abejas subpleural
- Antifibróticos

Ficha n.° 37 · p. 22

B NINE: vidrio esmerilado

- Vidrio esmerilado
- Mesenquimopatías

Ficha n.° 39 · p. 23

LA DIFERENCIA En la FPI los corticoides están contraindicados.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

SDRA vs edema cardiogénico



VS



A Síndrome de distrés respiratorio agudo

- Opacidades bilaterales
- Corazón normal

Ficha n.° 48 · p. 28

B Edema pulmonar cardiogénico

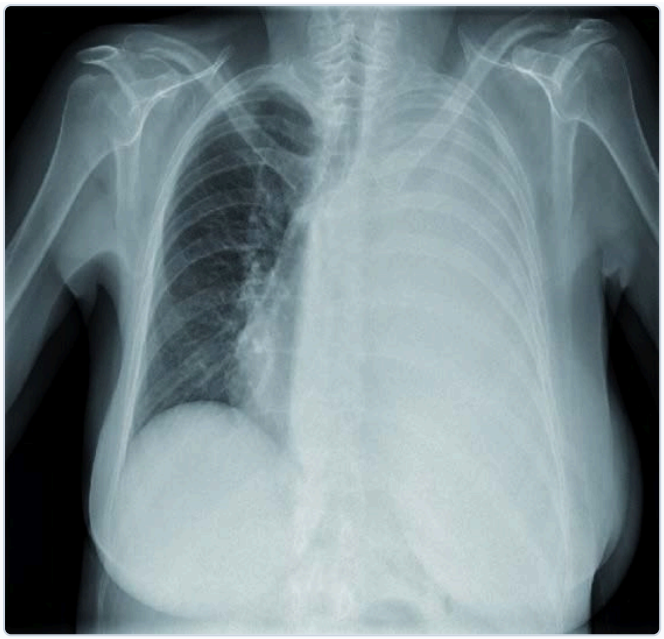
- Cardiomegalia
- Responde al diurético

Ficha n.° 49 · p. 28

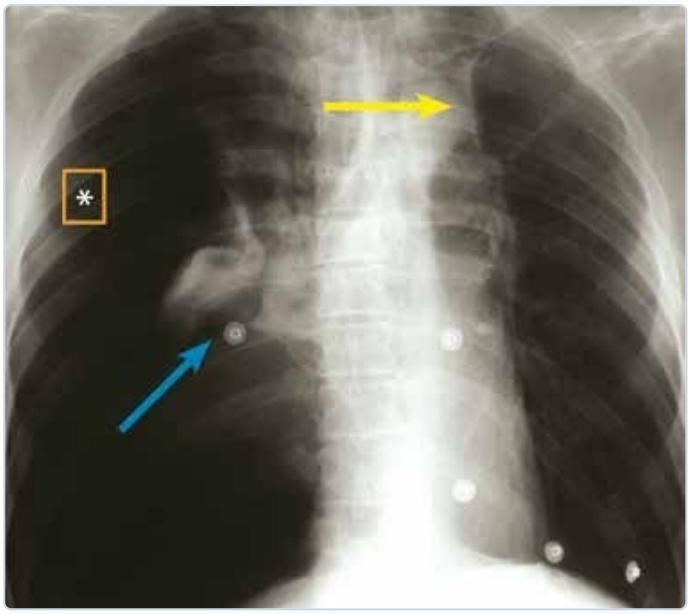
LA DIFERENCIA El ecocardiograma decide si la falla cardíaca explica el cuadro.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Derrame masivo vs neumotórax a tensión



VS



A **Derrame pleural masivo izquierdo**

- Hemitórax blanco
- Matidez

Ficha n.° 20 · p. 13

B **Neumotórax a tensión**

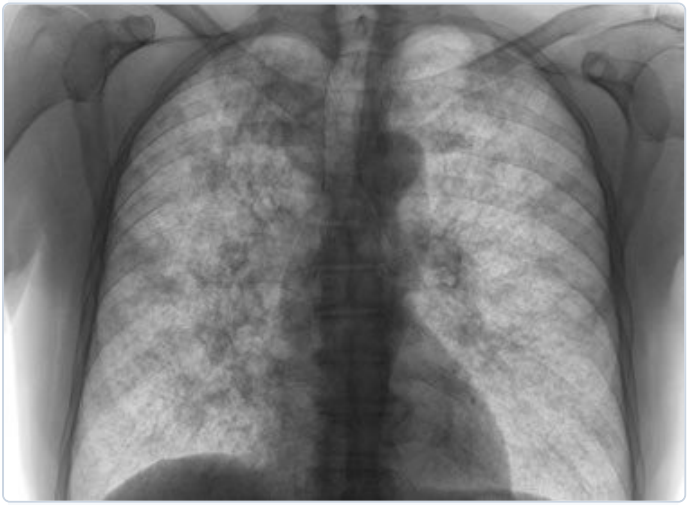
- Hemitórax negro
- Timpanismo, shock

Ficha n.° 23 · p. 15

LA DIFERENCIA Ambos empujan el mediastino; el neumotórax a tensión se descomprime sin radiografía.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

TBC miliar vs silicosis



VS



A **TBC miliar en la radiografía**

- Micronódulos difusos

Ficha n.° 16 · p. 11

B **Silicosis crónica**

- Nódulos en lóbulos superiores

Ficha n.° 40 · p. 23

LA DIFERENCIA La silicosis exige antecedente laboral y se asocia a TBC.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

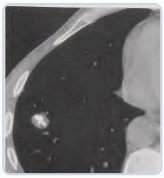


BRONCOGRAMA AÉREO

Bronquios con aire visibles dentro de la condensación.

Se ve en: Consolidación alveolar (neumonía).

Tomo p. 29 · Atlas: ficha n.° 08, p. 7

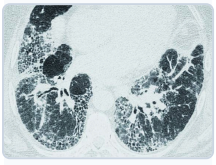


CALCIFICACIÓN EN PALOMITAS DE MAÍZ

Calcificación grumosa dentro de un nódulo con grasa.

Se ve en: Hamartoma pulmonar.

Tomo p. 74 · Atlas: ficha n.° 27, p. 17



PANAL DE ABEJAS

Quistes subpleurales apilados en las bases.

Se ve en: Fibrosis pulmonar idiopática (NIU).

Tomo p. 82 · Atlas: ficha n.° 37, p. 22

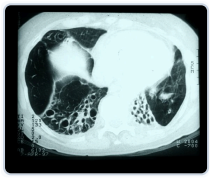
sin foto en el atlas

CREPITANTES TIPO VELCRO

Crepitantes secos bibasales.

Se ve en: Fibrosis pulmonar idiopática.

Tomo p. 83

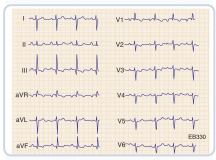


SIGNO DEL ANILLO DE SELLO

Bronquio más ancho que la arteria que lo acompaña.

Se ve en: Bronquiectasias.

Tomo p. 93 · Atlas: ficha n.° 46, p. 27



S1Q3T3 (MCGINN-WHITE)

S en DI, Q y T negativa en DIII.

Se ve en: Tromboembolismo pulmonar.

Tomo p. 85 · Atlas: ficha n.° 43, p. 25

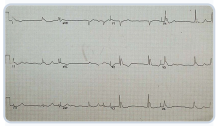
sin foto en el atlas

SÍNDROME DE HORNER

Ptosis, miosis y anhidrosis ipsilateral.

Se ve en: Tumor de Pancoast.

Tomo p. 80

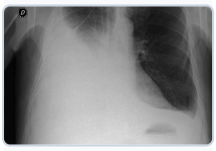


ONDA J DE OSBORN

Joroba al final del QRS.

Se ve en: Hipotermia.

Tomo p. 112 · Atlas: ficha n.° 55, p. 32



CRITERIOS DE LIGHT

Proteínas LP/S > 0,5, LDH LP/S > 0,6 o LDH LP > 2/3 del límite sérico.

Se ve en: Exudado pleural.

Tomo p. 52 · Atlas: ficha n.° 17, p. 12



EDEMA EN ESCLAVINA

Edema de cara, cuello y brazos.

Se ve en: Síndrome de vena cava superior.

Tomo p. 77 · Atlas: ficha n.° 36, p. 21

Signos con nombre propio · continuación



CÁSCARA DE HUEVO

Calcificación periférica de las adenopatías hiliares.

Se ve en: Silicosis.

Tomo p. 81 · Atlas: ficha n.° 40, p. 23

Índice por tipo de imagen

3	3	6	38	3	2
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA

Foto clínica · 3

34 Acropaquias (dedos en palillo de tambor) (4.2) 20
36 Síndrome de vena cava superior (4.2) 21
42 Trombosis venosa profunda (4.4) 24

Histología / citología · 3

15 Baciloscopía (Ziehl-Neelsen) (2.5) 11
32 Adenocarcinoma de pulmón (4.2) 19
33 Carcinoma epidermoide (4.2) 20

Esquema · 6

01 Curvas flujo-volumen (1.1) 4
02 Inhalador con aerocámara (1.3) 4
03 Prueba broncodilatadora positiva (1.3) 5
05 Tipos de enfisema (1.4) 6
52 Apnea obstructiva en la polisomnografía (5.3) 30
53 Monóxido de carbono y curva de disociación (5.4) 30

Imagen radiológica · 38

04 EPOC: hiperinsuflación (1.4) 5
06 Enfisema centrolobulillar en la TAC (1.4) 6
07 Neumonía: consolidación lobar (2.1) 7
08 Broncograma aéreo (2.1) 7
09 Neumonía por Mycoplasma (2.3) 8
10 Neumonía aspirativa (2.3) 8
11 Neumonía por Klebsiella (2.3) 9
12 Absceso pulmonar (2.4) 9
13 Quiste hidatídico pulmonar complicado (2.4) 10
14 Aspectos radiológicos de la TBC (2.5) 10
16 TBC miliar en la radiografía (2.5) 11
17 Derrame pleural (3.1) 12
19 Derrame encapsulado (3.2) 13
20 Derrame pleural masivo izquierdo (3.2) 13
21 Derrame pleural en la Rx de tórax (3.2) 14
22 Neumotórax: inspiración y espiración (3.3) 14
23 Neumotórax a tensión (3.4) 15
24 Tórax volante (3.4) 15
25 Derrame pleural masivo (3.5) 16
26 Mesotelioma pleural (3.5) 16
27 Hamartoma: calcificación en palomitas de maíz (4.1) 17
28 Masa pulmonar de bordes irregulares (4.1) 17
29 Nódulo parcialmente sólido (4.1) 18
30 Nódulo pulmonar espiculado (4.1) 18
31 PET-CT: nódulo hipercaptante (4.1) 19
35 Síndrome de vena cava superior en la TAC (4.2) 21
37 Fibrosis pulmonar idiopática: panal de abejas (4.3) 22
38 Fibrosis pulmonar en la radiografía (4.3) 22
39 NINE: vidrio esmerilado (4.3) 23
40 Silicosis crónica (4.3) 23
41 Asbestosis en la TACAR (4.3) 24
44 AngioTAC: defecto de llenado (4.4) 26
46 Bronquiectasias (4.5) 27
47 Bronquiectasias graves (4.5) 27
48 Síndrome de distrés respiratorio agudo (5.2) 28
49 Edema pulmonar cardiogénico (5.2) 28
50 Líneas B de Kerley (5.2) 29
54 Ahogamiento: edema pulmonar no cardiogénico (5.5) 31

Trazado (ECG / registro) · 3

43 ECG en TEP: S1Q3T3 (4.4) 25
51 Polisomnografía (5.3) 29
55 Hipotermia: onda J de Osborn (5.5) 32

Ecografía · 2

18 Ecografía pleural: derrame (3.1) 12
45 Ecocardiograma: VD dilatado (4.4) 26

Autoevaluación

18 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



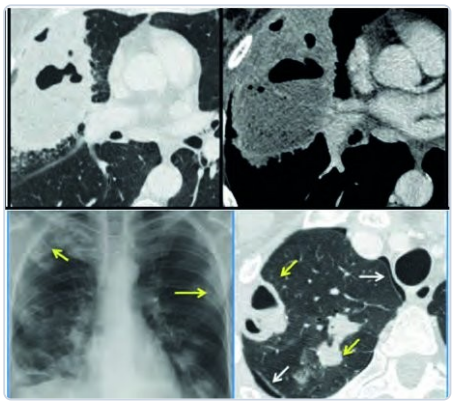
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



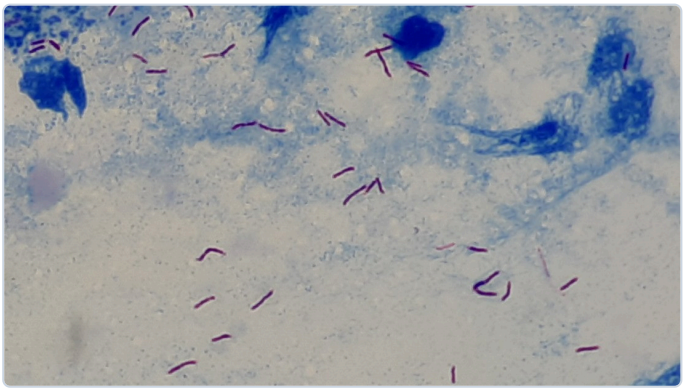
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



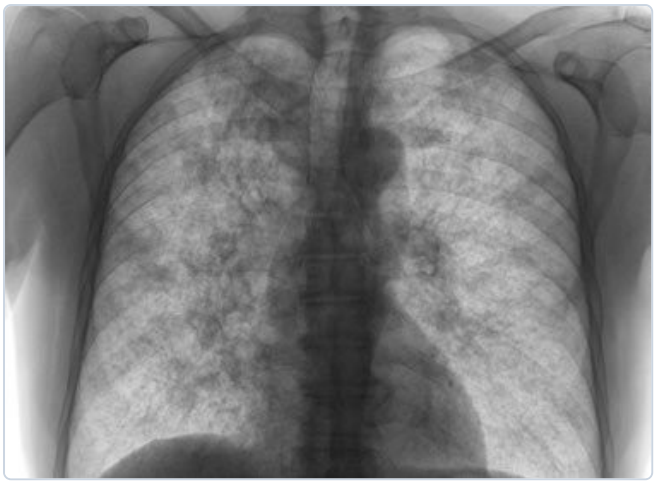
5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



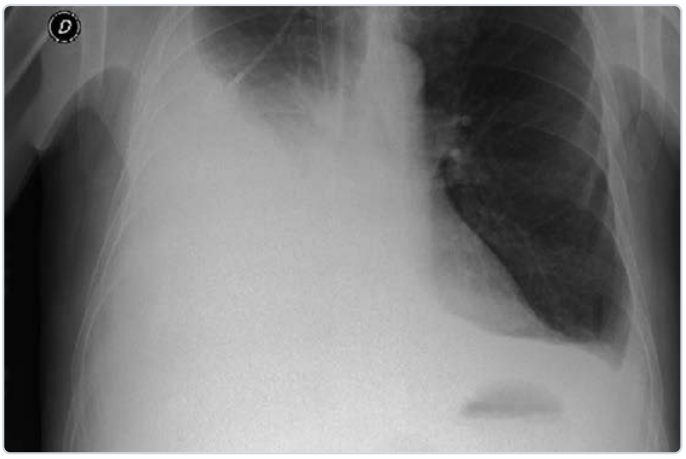
6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



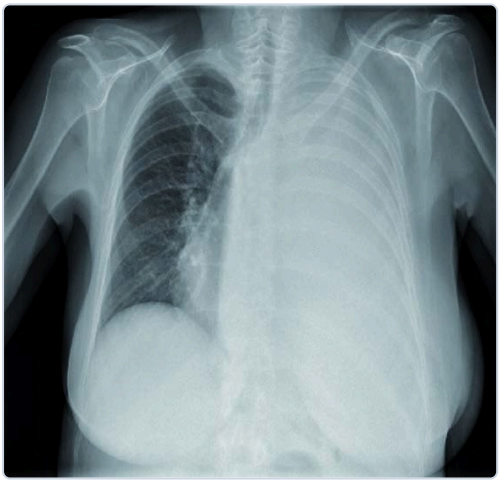
7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



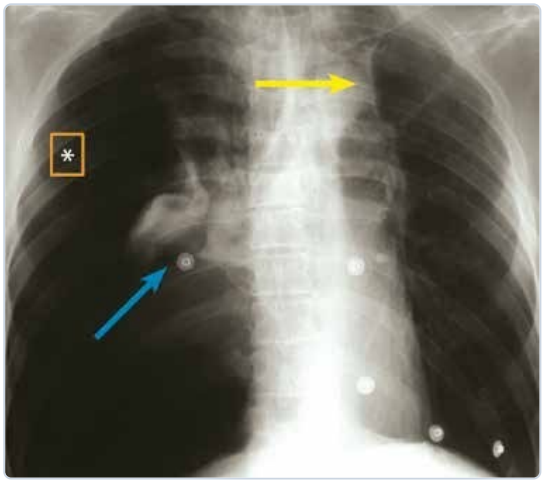
8 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



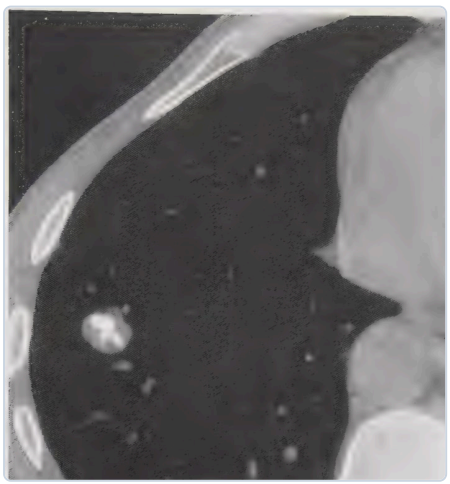
9 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



10 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



11 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



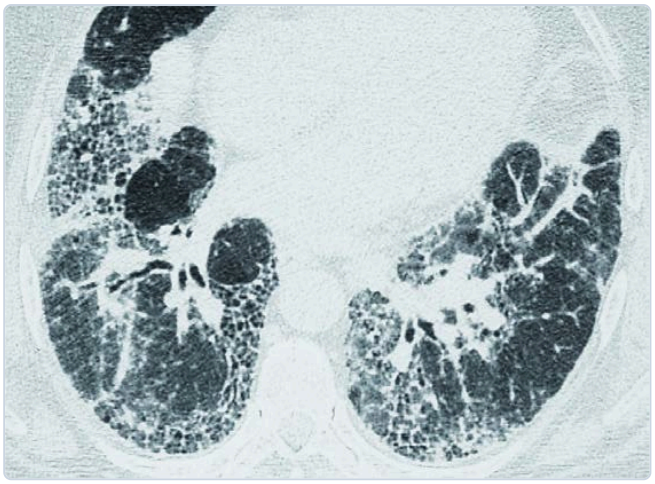
12 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



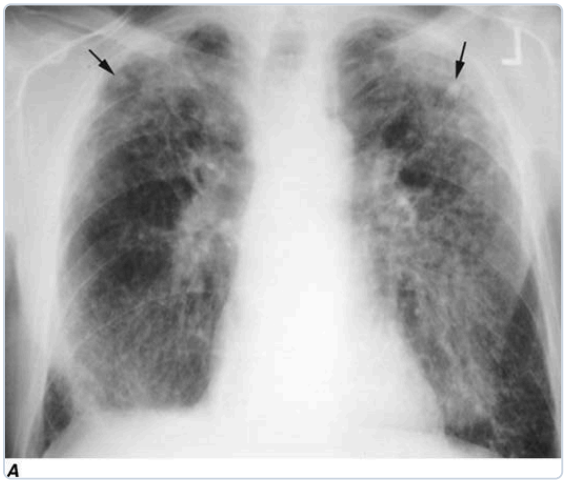
13 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



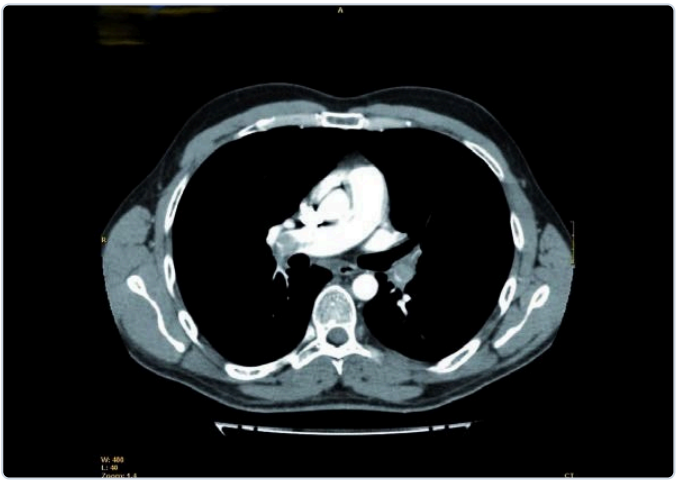
14 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



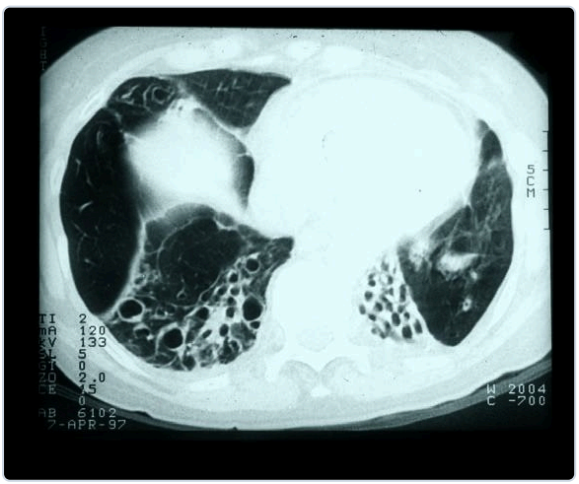
15 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



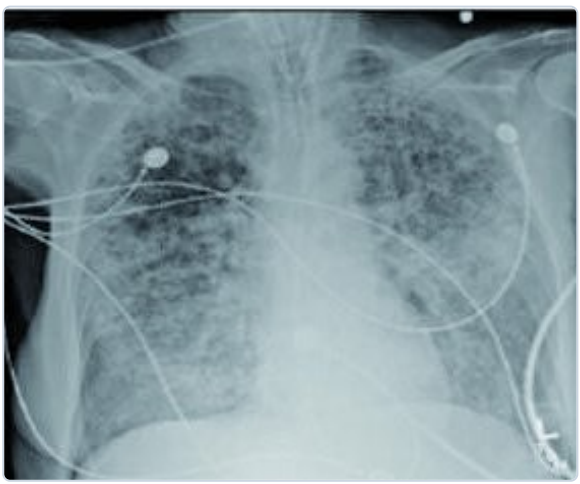
16 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



17 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



18 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**EPOC: hiperinsuflación**	Diafragma aplanado	04 · p. 5
2	**Neumonía: consolidación lobar**	Consolidación del lóbulo superior derecho	07 · p. 7
3	**Neumonía por Mycoplasma**	Infiltrado perihiliar bilateral	09 · p. 8
4	**Absceso pulmonar**	Cavidad con nivel hidroaéreo	12 · p. 9
5	**Quiste hidatídico pulmonar complicado**	Media luna de aire sobre el quiste	13 · p. 10
6	**Baciloscopía (Ziehl-Neelsen)**	Bacilos (BAAR)	15 · p. 11
7	**TBC miliar en la radiografía**	Micronódulos difusos	16 · p. 11
8	**Derrame pleural**	Menisco pleural	17 · p. 12
9	**Derrame pleural masivo izquierdo**	Hemitórax izquierdo opaco	20 · p. 13
10	**Neumotórax a tensión**	Pulmón colapsado (flecha azul)	23 · p. 15
11	**Hamartoma: calcificación en palomitas de maíz**	Calcificación en popcorn	27 · p. 17
12	**Nódulo pulmonar espiculado**	Nódulo de bordes espiculados	30 · p. 18
13	**Acropaquias (dedos en palillo de tambor)**	Uñas en vidrio de reloj y pulpejo engrosado	34 · p. 20
14	**Fibrosis pulmonar idiopática: panal de abejas**	Panal de abejas subpleural	37 · p. 22
15	**Silicosis crónica**	Nódulos en los lóbulos superiores (flechas)	40 · p. 23
16	**AngioTAC: defecto de llenado**	Émbolo en la arteria pulmonar	44 · p. 26
17	**Bronquiectasias**	Bronquios dilatados	46 · p. 27
18	**Síndrome de distrés respiratorio agudo**	Infiltrado alveolar bilateral	48 · p. 28